

Impact de la nouvelle définition de cas SARI sur la surveillance des infections respiratoires virales sévères

**Résultats des données de surveillance SARI :
13 novembre 2023 – 5 septembre 2025**

13 avril 2026

**Y. Lafort • Y. Dockx • P. Mpakaniye • S. Denayer • F. De Keersmaecker • S. Hanoteaux •
BELSARI-NET Research Group* • L. De Mot**

*Les membres du BELSARI-NET Research Group sont consultables en suivant ce [lien](#)

Avec l'aide financière de



Merci de citer cette publication comme suit : Y. Lafort, Y. Dockx, P. Mpakaniye, S. Denayer, F. De Keersmaecker, S. Hanoteaux, BELSARI-NET Research Group, L. De Mot. Impact de la nouvelle définition de cas SARI sur la surveillance des infections respiratoires virales sévères. Bruxelles, Belgique : Sciensano ; 2025 34p. Numéro de rapport : D/2026.14.440/41. Disponible en ligne : XXX

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La nouvelle définition de cas SARI détecte mieux les infections virales respiratoires autres que la grippe et identifie principalement des infections plus graves

La nouvelle définition de cas permet d'identifier un nombre substantiel de cas supplémentaires des principales infections virales respiratoires, en particulier des cas additionnels de VRS. Il s'agit principalement de cas plus graves qui ne s'accompagnent pas de fièvre.

Une nouvelle définition de cas SARI a été introduite afin de mieux détecter les infections respiratoires autres que la grippe

La définition de cas SARI existante, développée par l'Organisation mondiale de la Santé, était principalement axée sur la détection des cas de grippe. En raison de l'importance croissante d'autres infections virales respiratoires, une définition de cas plus large a été introduite en Belgique en 2023, dans le but d'améliorer la détection notamment des cas de VRS et de COVID-19, en particulier chez les jeunes enfants et les personnes âgées.

La nouvelle définition de cas détecte mieux les cas de VRS et de COVID-19, bien que principalement chez les adultes et les enfants de moins de 6 mois

La nouvelle définition de cas détecte effectivement davantage de cas de COVID-19 et surtout de VRS que de cas de grippe. Cette augmentation s'observe principalement chez les adultes, et en particulier chez les personnes âgées, mais aussi chez les enfants de moins de 6 mois pour le VRS. Le taux de positivité des agents pathogènes testés était toutefois nettement plus faible que celui observé avec l'ancienne définition de cas SARI.

Les cas SARI supplémentaires détectés présentent un tableau clinique plus sévère

Les patients qui ne répondent pas à l'ancienne définition de cas mais bien à la nouvelle présentent des symptômes plus graves à l'admission, ont plus souvent des comorbidités respiratoires et cardiaques, sont plus fréquemment admis en soins intensifs et présentent un taux de mortalité plus élevé.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION	5
2. MÉTHODOLOGIE	6
2.1. Réseau SARI	6
2.2. Population étudiée et période d'étude	6
2.3. Analyses	7
3. RÉSULTATS	7
3.1. Nombre de cas supplémentaires détectés de grippe, de VRS, de COVID-19 et de hMPV	7
3.2. Profil des patients répondant uniquement à la nouvelle définition de cas comparé à ceux répondant à l'ancienne définition de cas	12
3.2.1. Caractéristiques sociodémographiques	12
3.2.2. Symptômes	13
3.2.3. Comorbidités	14
3.2.4. Évolution de la maladie	15
4. DISCUSSION	17
4.1. Différences de profil	17
4.2. Impact sur la surveillance SARI	18
4.3. Limitations de l'étude	18
5. CONCLUSION	18
RÉFÉRENCES	19
ANNEXE: TABLEAU AVEC ANALYSES COMPLÉMENTAIRES	21

1. INTRODUCTION

Une surveillance adéquate des infections virales respiratoires est importante, car les agents pathogènes viraux peuvent provoquer de grandes épidémies et pandémies et constituent une cause majeure d'hospitalisation et de mortalité à l'échelle mondiale (1). Depuis 1999, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande une définition de cas pour les syndromes grippaux (« influenza-like illness », ILI) afin de surveiller les variations saisonnières de l'activité grippale et d'identifier les patients les plus appropriés pour la surveillance virologique (2). En 2011, l'OMS, notamment en réponse à la pandémie de grippe A(H1N1) de 2009–2010, a développé une définition de cas globale pour les infections respiratoires aiguës sévères (« severe acute respiratory infection », SARI) afin de surveiller les cas graves d'infection grippale (2,3). Un cas de SARI a été défini comme « une affection respiratoire aiguë avec des antécédents de fièvre ou une fièvre mesurée $\geq 38^{\circ}\text{C}$ et une toux, avec un début dans les 7 derniers jours, nécessitant une hospitalisation ». En 2014, une évaluation des données disponibles a indiqué que les patients atteints de SARI se présentant entre sept et dix jours après le début des symptômes n'étaient pas moins susceptibles d'être positifs en laboratoire pour la grippe que ceux se présentant plus tôt ; la période a donc été étendue à 10 jours (2).

Bien que la définition de cas SARI semblait suffisamment adéquate pour la surveillance des formes graves de grippe (4–6), elle s'est révélée moins efficace pour détecter le virus respiratoire syncytial (VRS), notamment parce que la fièvre était un symptôme obligatoire (7–9). L'OMS a évalué la performance de cette définition de cas dans 14 pays et a conclu que l'exigence de fièvre réduisait effectivement la sensibilité pour détecter les cas de VRS chez les jeunes enfants (10). C'est pourquoi une définition de cas « SARI élargie » a été développée pour la surveillance hospitalière des infections graves à VRS (11). Dans cette définition, la fièvre n'est plus un symptôme obligatoire et tous les patients présentant une infection respiratoire (définie comme « toux [dans certains contextes toux ou dyspnée] ») nécessitant une hospitalisation et dont les symptômes ont débuté au cours des 10 derniers jours sont considérés comme des cas SARI. Pour les enfants de moins de 6 mois, l'apnée (définie comme un arrêt temporaire de la respiration, quelle qu'en soit la cause) et/ou le sepsis (défini comme une fièvre $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ ou une hypothermie $< 35,5^{\circ}\text{C}$, et un état de choc [léthargie, respiration rapide, peau froide, temps de recoloration capillaire prolongé, pouls rapide et faible], et un état grave sans cause évidente) sont ajoutés comme critères supplémentaires. La définition de cas du VRS n'a pas pour objectif de remplacer ou de modifier la définition SARI utilisée pour la surveillance de la grippe, mais de soutenir les prestataires de soins dans la décision de quels agents pathogènes respiratoires doivent être testés.

En Belgique, la surveillance SARI a été mise en place en 2012 en utilisant la définition de cas de l'OMS. Une étude de la saison 2018/2019 a montré que la surveillance du VRS pouvait être considérablement améliorée en la démarrant plus tôt (celle-ci ne débutait alors qu'à la fin du mois de décembre) et en utilisant une définition de cas plus large, incluant des symptômes cliniques supplémentaires et sans exigence de fièvre (9). En novembre 2023, une nouvelle définition de cas a été introduite afin de mieux détecter les infections virales respiratoires se présentant sans fièvre, en particulier les infections à VRS et SARS-CoV-2 ainsi que celles touchant les personnes âgées et les nourrissons. La définition a été étendue à tous les patients hospitalisés pendant ≥ 24 heures, présentant au moins deux symptômes respiratoires aigus (fièvre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ou antécédents de fièvre, toux, signes de détresse respiratoire telle que dyspnée ou battement des ailes du nez chez les jeunes enfants, ou auscultation pulmonaire anormale, et chez les jeunes enfants également cyanose ou apnée), avec un début des symptômes dans les 10 jours précédant l'admission, et en excluant les infections nosocomiales (début des symptômes > 24 heures après l'admission). En plus de la définition de SARI, un deuxième indicateur est utilisé pour les cas de SARI présentant une évolution sévère, appelé « SARI avec complications ». Un cas de SARI est considéré comme compliqué en présence d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), d'une admission en soins intensifs, d'un traitement par oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO), d'une ventilation invasive ou d'un décès.

Deux ans après son introduction, nous avons évalué l'impact de la nouvelle définition de cas sur la surveillance des infections virales respiratoires sévères.

2. MÉTHODOLOGIE

2.1. Réseau SARI

Les données présentées dans ce rapport proviennent du réseau SARI, un réseau sentinelle d'hôpitaux belges qui enregistre tous les cas d'infections respiratoires aiguës sévères, coordonné par Sciensano. Cette surveillance a pour objectif de détecter précocement les signes d'une augmentation de la gravité de la grippe saisonnière et d'autres infections respiratoires aiguës, et de les signaler aux autorités sanitaires, tant au niveau national qu'international, notamment au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et à l'Organisation mondiale de la Santé.

Le réseau SARI a été lancé en 2012 et comptait jusqu'en novembre 2023 six hôpitaux participants. De novembre 2023 à novembre 2024, ils étaient au nombre de dix, puis neuf depuis lors. Le réseau couvre des patients provenant de 9 des 10 provinces belges et se compose d'hôpitaux disposant d'une activité importante en soins intensifs (ICU). Tous les services de ces hôpitaux participent à la surveillance. Pour chaque hospitalisation pour SARI, les hôpitaux assurent un suivi des patients pendant toute la durée du séjour et enregistrent différents paramètres. Les informations collectées comprennent les caractéristiques démographiques, les symptômes, les facteurs de risque et les comorbidités, les traitements, la gravité et l'issue clinique. En plus de cet enregistrement des données cliniques, un échantillon est prélevé chez chaque patient et analysé pour les virus respiratoires par le Centre national de référence (CNR) pour les pathogènes respiratoires. L'influenza et le SARS-CoV-2 sont testés toute l'année, tandis que les autres pathogènes ne le sont que pendant la saison hivernale. Pour le VRS et le hMPV (métapneumovirus humain), cette période s'étend de septembre (semaine 37) à fin avril (semaine 17), et pour les autres pathogènes de début octobre (semaine 40) à fin avril.

2.2. Population étudiée et période d'étude

Nous avons utilisé la base de données du réseau SARI à partir de la date d'introduction de la nouvelle définition de cas (13 novembre 2023) jusqu'au 5 septembre 2025. Tous les patients répondant à la nouvelle définition de cas ont été inclus dans l'analyse.

La nouvelle définition de cas SARI est définie comme :

- une hospitalisation d'au moins 24 heures,
- pour **au moins 2 des symptômes sévères suivants** d'infection respiratoire aiguë :
 - o fièvre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ou antécédents de fièvre
 - o toux
 - o signes de détresse respiratoire (y compris, mais sans s'y limiter, la dyspnée)
 - o auscultation pulmonaire anormale
 - o et chez les enfants de < 5 ans : apnée ou cyanose
- d'apparition aiguë (dans les 10 jours précédant l'admission),
- les infections nosocomiales étant exclues (début des symptômes > 24 heures après l'admission).

L'ancienne définition de cas était :

- une hospitalisation d'au moins 24 heures,
- pour des symptômes sévères d'infection respiratoire aiguë, définis comme fièvre ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) **et** toux et/ou détresse respiratoire,
- d'apparition aiguë (dans les 10 jours précédant l'admission),
- les infections nosocomiales étant exclues.

Tous les patients répondant à l'ancienne définition de cas répondent donc également à la nouvelle.

Un SARI est considéré comme « SARI avec complications » en cas de :

- survenue d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA),

- admission en soins intensifs,
- nécessité d'un traitement par oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO) ou ventilation invasive,
- décès du patient.

2.3. Analyses

Une analyse descriptive a été réalisée selon un plan de cohorte observationnelle rétrospective, comparant le profil des patients répondant à l'ancienne définition de cas à celui des patients répondant uniquement à la nouvelle définition (appelés dans le reste du rapport « uniquement nouvelle définition de cas »). Dans un premier temps, le degré d'augmentation du nombre de cas détectés a été évalué, avec une attention particulière portée à la grippe, au VRS, au COVID-19 et au hMPV. Pour la grippe et le COVID-19, testés toute l'année, l'analyse a porté sur l'ensemble des patients SARI, tandis que pour le VRS et le hMPV, seuls les patients hospitalisés durant la période de test (du 1^{er} septembre au 30 avril) ont été inclus. Cette analyse a été réalisée pour l'ensemble des patients SARI, ainsi que séparément pour les enfants de 0–5 ans, les enfants et adultes de 6–64 ans, et les adultes de 65 ans et plus. Cette stratification a été choisie car ces groupes étaient suffisamment homogènes et comptaient un nombre de patients suffisant. Elle a également été effectuée pour la sous-catégorie des nourrissons de 0–6 mois, car l'amélioration de la détection du VRS dans ce groupe constituait un objectif spécifique de la nouvelle définition de cas. Les différences de pourcentage d'augmentation du nombre de cas détectés de grippe, VRS, COVID-19 et hMPV ont été testées pour leur significativité statistique à l'aide d'un test du chi carré. Les co-infections ont été exclues de cette analyse.

Ensuite, le profil des patients répondant uniquement à la nouvelle définition de cas a été comparé à celui des patients répondant à l'ancienne définition en termes de caractéristiques sociodémographiques, symptômes, comorbidités, évolution de la maladie et issue clinique. Les patients présentant des données manquantes pour une variable donnée ont été systématiquement exclus de l'analyse correspondante. Un modèle de régression logistique multivariée ajusté sur l'âge, réparti en 5 catégories (0–4 ; 5–17 ; 18–64 ; 65–79 ; 80+ ans), a été utilisé. Cette analyse a été réalisée pour l'ensemble des patients SARI, ainsi que séparément pour les quatre principaux pathogènes (grippe, VRS, COVID-19 et hMPV). Les co-infections ont été exclues. Elle a également été effectuée séparément pour les groupes d'âge 0–5 ans, 6–64 ans et 65 ans et plus, avec ajustement pour l'âge en tant que variable continue au sein de chaque groupe. Pour les variables binaires, des rapports de cotes (odds ratio) ajustés avec leurs intervalles de confiance à 95 % et des valeurs p bilatérales ont été calculés, une valeur $p < 0,05$ étant considérée comme statistiquement significative. Pour les variables continues, un modèle de régression linéaire a été utilisé pour les moyennes et un modèle de régression quantile pour les médianes, avec dans chaque cas le calcul du coefficient de régression, de l'intervalle de confiance à 95 % et des valeurs p bilatérales.

3. RÉSULTATS

3.1. Nombre de cas supplémentaires détectés de grippe, de VRS, de COVID-19 et de hMPV

Au cours de la période du 13 novembre 2023 au 5 septembre 2025, 12 446 patients SARI ont été rapportés par les hôpitaux sentinelles. Parmi eux, 7 966 patients (64,0 %) répondaient à l'ancienne définition de cas et 4 135 (33,2 %) répondaient uniquement à la nouvelle définition de cas. Pour 345 patients (2,8 %), les données étaient insuffisantes pour déterminer s'ils répondaient également à l'ancienne définition de cas ; ils ont été exclus des analyses ultérieures.

Le tableau 1 présente le nombre de cas de grippe, de VRS, de COVID-19 et de hMPV détectés avec la nouvelle définition de cas, le nombre et la proportion de ces cas également captés par l'ancienne définition

de cas (sensibilité relative de l'ancienne définition), ainsi que le nombre et la proportion de cas détectés uniquement par la nouvelle définition de cas.

Tableau 1: Nombre de cas détectés de grippe, de VRS, de COVID-19 et de hMPV ; pourcentage détecté par l'ancienne définition de cas SARI et uniquement par la nouvelle définition de cas, par catégorie d'âge

	Grippe		VRS		COVID-19		hMPV	
	N	%	n	%	n	%	n	%
Tous âges	<i>N=1602</i>		<i>N=1122</i>		<i>N=902</i>		<i>N=554</i>	
Ancienne définition de cas	1276	79,7 %	847	75,5 %	655	72,6 %	439	79,2 %
Uniquement nouvelle définition de cas	326	20,3 %	275	24,5 %	247	27,4 %	115	20,8 %
0-6 mois	<i>N=109</i>		<i>N=295</i>		<i>N=122</i>		<i>N=108</i>	
Ancienne définition de cas	104	95,4 %	218	73,9 %	110	90,2 %	97	89,8 %
Uniquement nouvelle définition de cas	5	4,6 %	77	26,1 %	12	9,8 %	11	76,7 %
0-5 ans	<i>N=393</i>		<i>N=710</i>		<i>N=165</i>		<i>N=288</i>	
Ancienne définition de cas	379	96,4 %	610	85,9 %	150	90,9 %	268	93,1 %
Uniquement nouvelle définition de cas	14	3,6 %	100	14,1 %	15	9,1 %	20	6,9 %
6-64 ans	<i>N=432</i>		<i>N=111</i>		<i>N=144</i>		<i>N=71</i>	
Ancienne définition de cas	365	84,5 %	72	64,9 %	109	75,7 %	55	77,5 %
Uniquement nouvelle définition de cas	67	15,5 %	39	35,1 %	35	24,3 %	16	22,5 %
≥65 ans	<i>N=777</i>		<i>N=301</i>		<i>N=593</i>		<i>N=195</i>	
Ancienne définition de cas	532	68,5 %	165	54,8 %	396	66,8 %	116	59,5 %
Uniquement nouvelle définition de cas	245	31,5 %	136	45,2 %	197	33,2 %	79	40,5 %

Tableau 2: Pourcentage d'augmentation avec la nouvelle définition de cas SARI du nombre de cas détectés de grippe, de VRS, de COVID-19 et de hMPV, par catégorie d'âge

	Tous âges	0-6 mois	0-5 ans	6-64 ans	≥65 ans
Grippe	25,5 %	4,8 %	3,7 %	18,4 %	46,1 %
VRS	32,5 %	35,3 %	16,4 %	54,2 %	82,4 %
COVID-19	37,7 %	10,9 %	10,0 %	32,1 %	49,7 %
hMPV	26,2 %	11,3 %	7,5 %	29,1 %	68,1 %
Valeur p VRS vs grippe*	0,014	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Valeur p VRS vs COVID-19*	0,028	0,002	0,129	0,172	0,016
Valeur p grippe vs COVID-19*	<0,001	0,094	0,004	0,016	0,394
Valeur p hMPV vs grippe*	0,637	0,106	0,035	0,119	0,014
Valeur p hMPV vs VRS*	0,106	<0,001	0,002	0,071	0,305
Valeur p hMPV vs COVID-19*	0,004	0,956	0,580	0,777	0,229

* Test du chi carré pour la comparaison du pourcentage d'augmentation

Le tableau 2 et la figure 1 présentent l'augmentation du nombre de cas SARI rapportés, ainsi que l'augmentation du nombre de cas supplémentaires détectés de grippe, de VRS, de COVID-19 et de hMPV. La nouvelle définition de cas permet d'identifier environ 52 % de cas SARI en plus. Par pathogène, davantage de cas de COVID-19 (augmentation de 38 %) et de VRS (33 %) sont détectés relativement à la grippe (26 %) et au hMPV (26 %). Lorsqu'on analyse par groupe d'âge, l'augmentation est plus importante avec l'âge et est systématiquement la plus élevée pour le VRS et la plus faible pour la grippe. Une exception concerne l'augmentation relativement plus élevée des cas de VRS chez les très jeunes enfants (0-6 mois) par rapport aux enfants plus âgés (figure 2).

Figure 1 • Augmentation du nombre de cas SARI rapportés et augmentation du nombre de cas de grippe, VRS, COVID-19 et hMPV détectés grâce à la nouvelle définition de cas

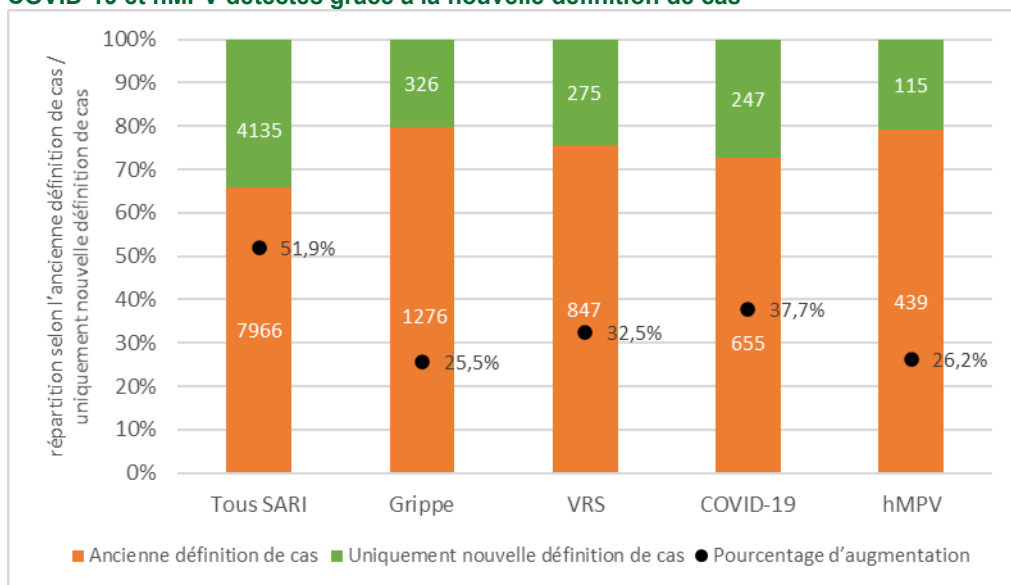
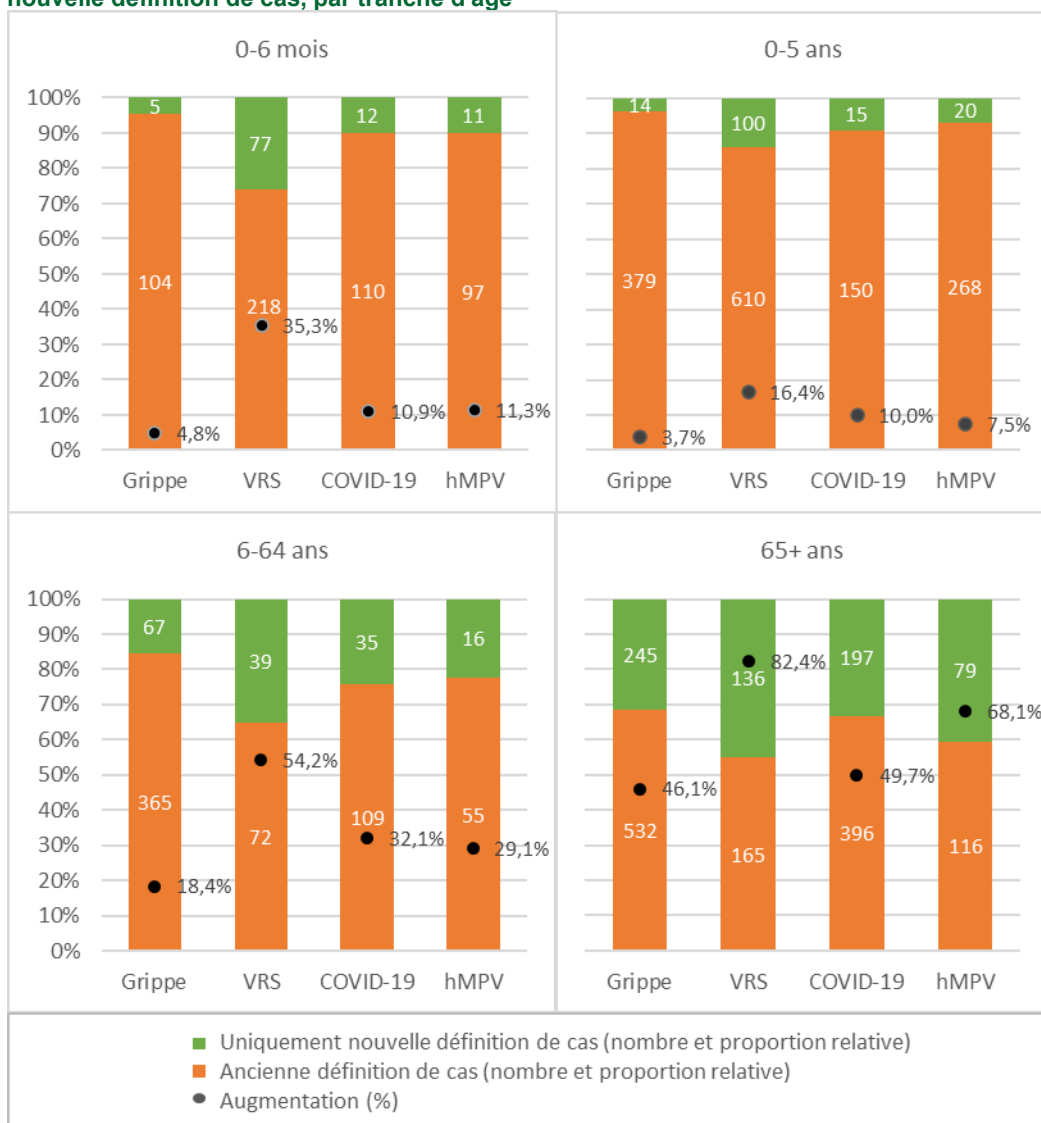


Figure 2 • Augmentation du nombre de cas détectés de grippe, de VRS, de COVID-19 et de hMPV suite à la nouvelle définition de cas, par tranche d'âge



La figure 3 illustre la différence entre les définitions de cas en termes d'incidence hebdomadaire, sur la période étudiée, du nombre total de patients atteints de SARI et du nombre de cas de grippe, de VRS, de COVID-19 et de hMPV recensés. Cette différence est constante dans le temps et suit une relation linéaire avec un coefficient de corrélation de 0,984 pour l'ensemble des patients SARI, et de 0,998, 0,986, 0,978 et 0,980 pour la grippe, le VRS, la COVID-19 et le hMPV, respectivement (figure 4).

Figure 3 • Incidence hebdomadaire des patients SARI par définition de cas et par agent pathogène, du 13 novembre 2023 au 5 septembre 2025

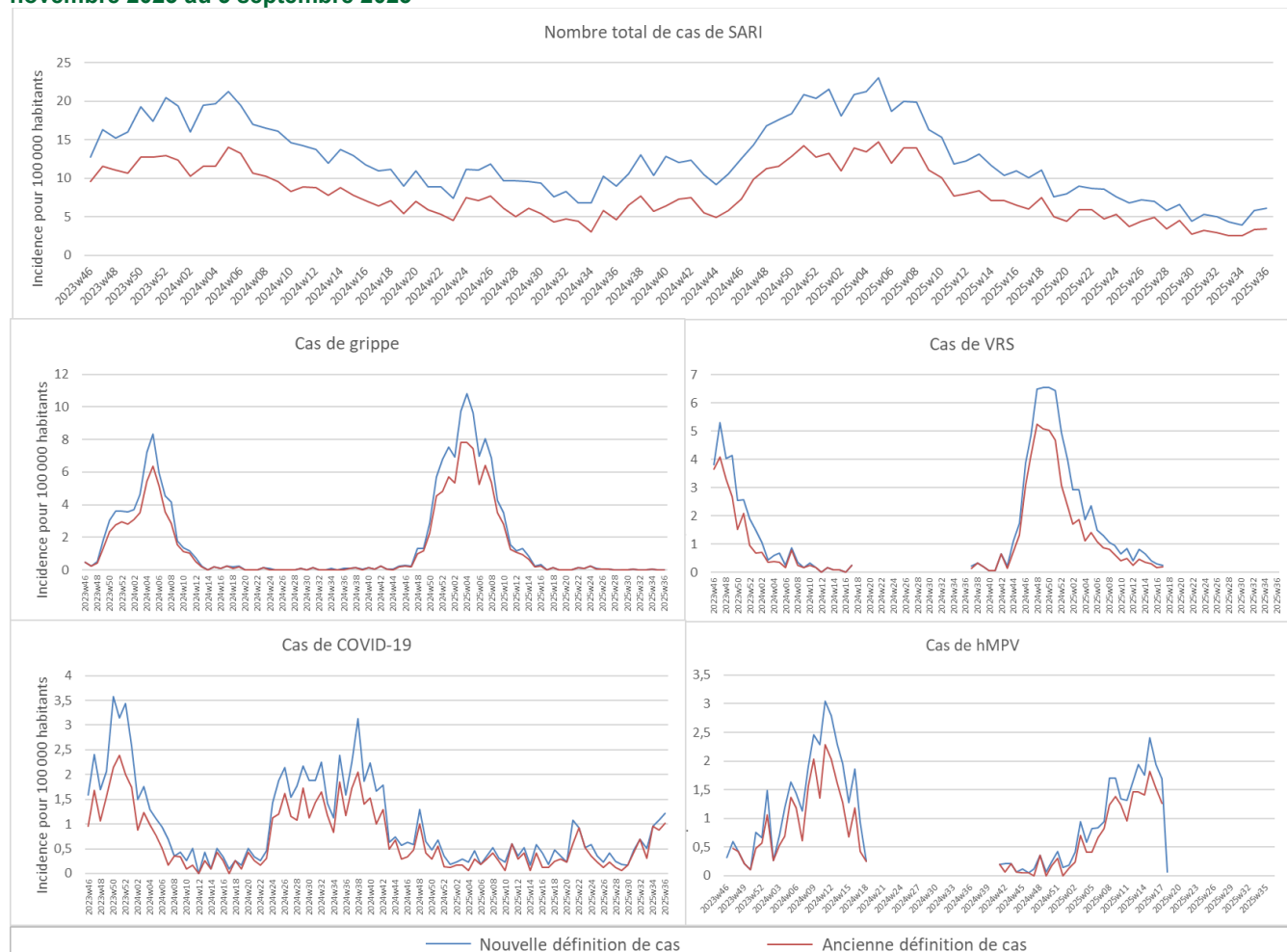
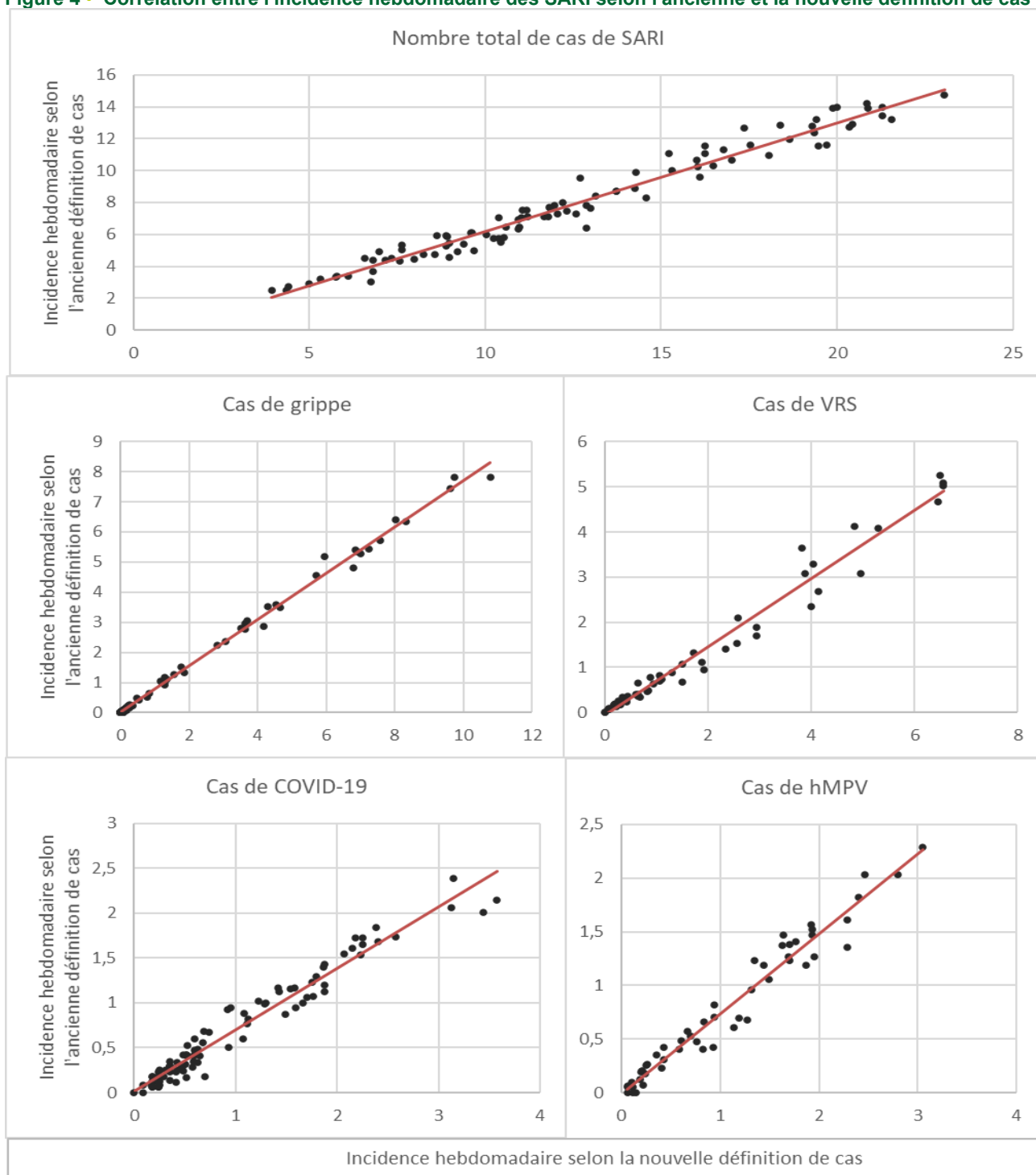


Figure 4 • Corrélation entre l'incidence hebdomadaire des SARI selon l'ancienne et la nouvelle définition de cas



Le taux de positivité des agents pathogènes testés est nettement (et généralement de manière statistiquement significative) plus faible chez les patients répondant uniquement à la nouvelle définition de cas que chez ceux répondant à l'ancienne définition de cas, et ce pour tous les agents pathogènes (tableau 3). La nouvelle définition de cas présente donc une spécificité plus faible. Cela s'explique principalement par le nombre plus élevé de patients dont les tests se sont révélés négatifs pour tous les agents pathogènes testés. Le pourcentage de patients chez lesquels aucun agent pathogène n'a été détecté était nettement plus élevé chez les patients répondant uniquement à la nouvelle définition de cas que chez ceux répondant à l'ancienne définition (30,9 % contre 51,9 % [$p < 0,001$] sur l'ensemble de la période, et 32,4 % contre 53,5 % [$p < 0,001$] pendant la saison hivernale). Les patients pour lesquels tous les résultats des tests n'étaient pas disponibles n'ont pas été pris en compte dans ce calcul.

Tableau 3: Taux de positivité des agents pathogènes testés*

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	Valeur p
Période totale	N=7966	N=4135	
Grippe	16,1 %	8,0 %	<0,001
SARS-CoV-2	8,3 %	6,0 %	<0,001
Saison hivernale	N=6079	N=3101	
VRS	14,1 %	9,0 %	<0,001
hMPV	7,3 %	3,8 %	<0,001
Entéro/rhinovirus	14,5 %	12,2 %	0,003
Virus para-influenza	3,9 %	2,8 %	0,008
Coronavirus saisonniers	3,8 %	3,6 %	0,712
Adénovirus	5,6 %	1,4 %	<0,001
Paréchovirus	0,38 %	<0,16 %	0,009
Bocavirus	2,3 %	0,8 %	<0,001

* Les patients dont les résultats des tests n'étaient pas connus ont été exclus

3.2. Profil des patients répondant uniquement à la nouvelle définition de cas comparé à ceux répondant à l'ancienne définition de cas

3.2.1. Caractéristiques sociodémographiques

La principale différence socio-démographique par rapport à l'ancienne définition de cas est que les patients répondant uniquement à la nouvelle définition sont en moyenne nettement plus âgés (Tableau 4). Alors que les enfants de 0 à 5 ans représentaient plus d'un tiers des patients SARI dans l'ancienne définition (35,1 %), ils ne constituent plus que 8,7 % dans uniquement la nouvelle définition. La proportion de personnes âgées de 80 ans et plus est, quant à elle, passée de 18,5 % à 33,1 %. Ce changement de profil d'âge est observé pour les quatre pathogènes principaux. Une exception concerne les nourrissons de 0 à 6 mois atteints de VRS, dont la proportion n'a pas diminué et a même légèrement augmenté par rapport à l'ancienne définition de cas. Les patients répondant uniquement à la nouvelle définition sont également relativement plus souvent de sexe féminin, ce qui vaut aussi pour les patients infectés par VRS et hMPV. La différence entre les sexes persiste après correction pour l'âge.

Tableau 4: Profil socio-démographique des patients SARI selon l'ancienne définition de cas et uniquement la nouvelle définition de cas

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	Valeur p
Tous patients SARI	(N=7966)	(N=4135)	
Âge en années (médiane)	55	73	<0,001
Âge en années (Q25-Q75)	1-76	62-83	
<= 6 mois	12,7 %	4,8 %	<0,001
<= 5 ans	35,1 %	8,7 %	
6-64 ans	23,4 %	20,9 %	<0,001
65-79 ans	23,1 %	37,3 %	
>=80 ans	18,5 %	33,1 %	
Féminin	45,0 %	49,0 %	<0,001
Résident en maison de repos*	15,4 %	17,1 %	0,075
Grippe	N=1212	N=310	
Âge en années (médiane)	58	74	<0,001
Âge en années (Q25-Q75)	4-76	65-84	
<= 6 mois	7,9 %	1,0 %	<0,001
<= 5 ans	27,9 %	3,2 %	
6-64 ans	29,2 %	20,3 %	<0,001
65-79 ans	23,6 %	41,9 %	

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	Valeur p
>=80 ans	19,3 %	34,5 %	
Féminin	48,6 %	49,4 %	0,812
Résident en maison de repos*	15,4 %	14,7 %	0,803
VRS	N=784	N=254	
Âge en années (médiane)	1	64,5	<0,001
Âge en années (Q25-Q75)	0-37	0-84	
<= 6 mois	26,0 %	29,1 %	0,330
<= 5 ans	72,3 %	37,0 %	
6-64 ans	8,4 %	13,0 %	<0,001
65-79 ans	9,2 %	18,9 %	
>=80 ans	10,1 %	31,1 %	
Féminin	42,6 %	55,9 %	<0,001
Résident en maison de repos*	22,3 %	24,8 %	0,631
COVID-19	N=614	N=240	
Âge en années (médiane)	74	78	0,005
Âge en années (Q25-Q75)	44,75-84	67,25-85	
<= 6 mois	15,8 %	4,2 %	<0,001
<= 5 ans	19,9 %	5,0 %	
6-64 ans	16,9 %	13,8 %	<0,001
65-79 ans	28,0 %	35,4 %	
>=80 ans	35,2 %	45,8 %	
Féminin	44,6 %	44,2 %	0,904
Résident en maison de repos*	14,5 %	18,6 %	0,210
hMPV	N=415	N=114	
Âge en années (médiane)	2	74,5	<0,001
Âge en années (Q25-Q75)	0-67	58,5-85	
<= 6 mois	22,2 %	9,7 %	0,003
<= 5 ans	60,0 %	17,5 %	
6-64 ans	12,8 %	14,0 %	<0,001
65-79 ans	16,1 %	34,2 %	
>=80 ans	11,1 %	34,2 %	
Féminin	51,3 %	62,3 %	0,038
Résident en maison de repos*	12,8 %	22,4 %	0,088

* N = uniquement les patients âgés de ≥ 65 ans

3.2.2. Symptômes

Le Tableau 5 présente la prévalence de différents symptômes à l'admission, selon la définition de cas. Étant donné que la fièvre, ou des antécédents de fièvre, était un symptôme requis dans l'ancienne définition de cas, tous les patients répondant à cette définition présentaient logiquement ce symptôme. Les patients répondant uniquement à la nouvelle définition de cas ont rarement de la fièvre (5 %) et présentent clairement un autre profil symptomatique. Les symptômes spécifiquement mentionnés dans la nouvelle définition — et non dans l'ancienne — (auscultation pulmonaire anormale, cyanose et apnée) sont, après correction pour les différences de distribution d'âge, relativement plus fréquents, comme on pouvait s'y attendre. Les problèmes respiratoires, la respiration sifflante, la tachypnée et la dépendance à l'oxygène sont également significativement plus fréquents dans le groupe répondant uniquement à la nouvelle définition. Chez les jeunes enfants répondant uniquement à la nouvelle définition, on rapporte également plus souvent un battement des ailes du nez, un geignement expiratoire, des rétractions intercostales subvertébrales, une hypopnée et un balancement thoraco-abdominal.

L'analyse par pathogène montre que la faible prévalence de la fièvre est observée pour les quatre pathogènes, mais elle est particulièrement marquée pour la grippe, le VRS et le hMPV. Seuls 3,2 % des nouveaux cas de grippe, 2,4 % des nouveaux cas de VRS et 3,5 % des nouveaux cas de hMPV présentaient de la fièvre, contre 10 % des nouveaux cas de COVID-19. Le profil symptomatique observé chez l'ensemble des patients SARI se retrouve pour les quatre pathogènes, bien que cela ne soit pas

toujours statistiquement significatif en raison du nombre plus limité de cas. Les résultats détaillés de l'analyse par pathogène, ainsi que ceux par groupe d'âge, sont disponibles en annexe.

Tableau 5: Différences de symptômes entre les patients SARI selon l'ancienne définition de cas et uniquement la nouvelle définition de cas

	Ancienne définition de cas (N=7966)	Uniquement nouvelle définition de cas (N=4135)	aOR	95 % CI	Valeur p
<i>Symptômes de l'ancienne définition de cas</i>					
Fièvre ^a	83,9 %	4,5 %	0,010	0,009-0,012	<0,001
Historique de fièvre ^a	60,9 %	2,1 %	0,016	0,013-0,020	<0,001
Fièvre et/ou historique de fièvre	100,0 %	5,0 %	-	-	-
Toux ^a	87,1 %	73,9 %	0,56	0,51-0,62	<0,001
Problèmes respiratoires ^a	69,2 %	88,1 %	2,26	2,02-2,53	<0,001
<i>Symptômes additionnels de la nouvelle définition de cas</i>					
Auscultation pulmonaire anormale ^a	66,3 %	86,7 %	2,66	2,39-2,96	<0,001
Cyanose ^a	5,1 %	11,1 %	2,35	1,62-3,41	<0,001
Apnée ^a	2,6 %	8,5 %	3,57	2,28-5,59	<0,001
<i>Autres symptômes</i>					
Anorexie/problèmes nutritionnels ^a	46,9 %	24,8 %	0,44	0,40-0,48	<0,001
Dépendance à l'oxygène ^a	58,7 %	77,5 %	1,52	1,38-1,68	<0,001
Rhinite	45,7 %	15,2 %	0,40	0,35-0,47	<0,001
Mal de gorge	20,9 %	5,6 %	0,24	0,20-0,30	<0,001
Vomissements	24,9 %	10,8 %	0,53	0,46-0,61	<0,001
Malaise	50,6 %	26,8 %	0,30	0,27-0,34	<0,001
Myalgies	18,7 %	6,3 %	0,22	0,18-0,27	<0,001
Nausée	16,5 %	9,9 %	0,50	0,43-0,58	<0,001
Diarrhée	19,6 %	9,7 %	0,52	0,44-0,60	<0,001
Fatigue	50,3 %	27,3 %	0,34	0,30-0,38	<0,001
Otite	4,5 %	0,7 %	0,42	0,25-0,70	0,001
Douleur thoracique	15,8 %	18,9 %	0,96	0,84-1,10	0,582
Bronchospasme	10,0 %	7,1 %	0,75	0,60-0,93	0,008
Œdème pulmonaire	2,7 %	2,7 %	0,63	0,45-0,89	0,009
Conscience altérée ^a	6,1 %	5,5 %	0,67	0,44-0,998	0,048
Convulsions ^a	4,5 %	1,7 %	0,42	0,21-0,83	0,013
Respiration sifflante ^a	31,4 %	47,9 %	1,56	1,31-1,85	<0,001
Battement des ailes du nez	9,3 %	11,7 %	1,28	0,82-2,00	0,270
Geignement expiratoire	12,2 %	14,5 %	1,17	0,77-1,78	0,463
Rétractions intercostales subvertébrales	20,0 %	37,5 %	2,37	1,74-3,24	<0,001
Balancement thoraco-abdominal	5,2 %	8,1 %	1,60	0,92-2,77	0,096
Hypotonie	2,9 %	2,7 %	0,93	0,39-2,21	0,870
Hypopnée	1,4 %	3,6 %	2,55	1,11-5,83	0,027
Tachypnée	21,3 %	29,3 %	1,52	1,10-2,10	0,012
Confusion	21,8 %	14,2 %	0,50	0,43-0,59	<0,001
Chute soudaine	13,9 %	11,0 %	0,70	0,58-0,84	<0,001

aOR = rapport de cotes ajusté, corrigé pour l'âge catégorisé en 0-4 ; 5-17 ; 18-64 ; 65-79 ; 80+

95% CI = Intervalle de confiance à 95 %

^a Symptômes dont la présence doit obligatoirement être rapportée

3.2.3. Comorbidités

Les patients répondant uniquement à la nouvelle définition de cas présentent plus fréquemment une affection sous-jacente que ceux répondant également à l'ancienne définition (Tableau 6). Cette différence est la plus marquée dans le groupe d'âge de 6 à 64 ans. Chez les jeunes enfants et les personnes âgées, l'écart est plus faible et n'est pas statistiquement significatif (voir le tableau supplémentaire par groupe d'âge en annexe). Les comorbidités qui, après correction pour l'âge, sont significativement plus fréquentes sont l'asthme, d'autres maladies respiratoires chroniques, les maladies cardiaques chroniques et l'hypertension. Les maladies respiratoires chroniques sont particulièrement surreprésentées. À l'inverse, l'obésité (après correction pour l'âge), l'immunodéficience, la transplantation de cellules souches, les cancers hématologiques, d'autres affections hématologiques, les troubles neurologiques, les troubles

neuromusculaires et les troubles cognitifs sont moins fréquents. Toutefois, comme il s'agit de pathologies moins courantes, leur impact sur la proportion globale de patients présentant au moins une affection sous-jacente est plus limité.

L'analyse par pathogène montre le même schéma pour les quatre principales infections, bien que cela ne soit pas toujours statistiquement significatif en raison du nombre plus faible de cas (voir le tableau supplémentaire par pathogène en annexe).

Tableau 6: Différences de comorbidités entre les patients SARI selon l'ancienne définition de cas et uniquement la nouvelle définition de cas

	Ancienne définition de cas (N=7966)	Uniquement nouvelle définition de cas (N=4135)	aOR	95 % CI	Valeur p
≥1 affection sous-jacente ^a	68,6 %	89,0 %	1,36	1,18-1,57	<0,001
Asthme ^a	9,0 %	11,0 %	1,15	1,00-1,32	0,037
Autre maladie respiratoire chronique ^a	19,4 %	41,9 %	2,02	1,85-2,21	<0,001
Maladie cardiovasculaire chronique ^a	24,0 %	44,7 %	1,43	1,31-1,57	<0,001
Hypertension ^a	24,1 %	40,8 %	1,24	1,13-1,36	<0,001
Diabète ^a	14,0 %	22,2 %	1,05	1,01-1,24	0,330
Obésité ^a	13,1 %	13,8 %	0,69	0,62-0,78	<0,001
Insuffisance hépatique ^a	2,6 %	3,2 %	0,86	0,68-1,08	0,182
Insuffisance rénale ^a	12,3 %	20,0 %	1,03	0,93-0,15	0,560
Immunodéficience ^a	10,1 %	7,7 %	0,52	0,45-0,59	<0,001
Transplantation d'un organe solide ^a	0,9 %	0,8 %	0,70	0,46-1,07	0,099
Transplantation de cellules souches	1,9 %	1,1 %	0,50	0,34-0,73	<0,001
Cancer solide	13,8 %	19,7 %	0,94	0,85-1,05	0,270
Cancer hématologique	6,5 %	5,0 %	0,51	0,43-0,60	<0,001
Maladie sanguine non maligne	5,3 %	4,0 %	0,51	0,41-0,64	<0,001
Troubles neurologiques	9,7 %	12,1 %	0,85	0,75-0,96	0,012
Troubles neuro-musculaires	3,7 %	2,1 %	0,43	0,33-0,55	<0,001
Troubles cognitifs	7,2 %	9,1 %	0,77	0,66-0,89	<0,001
Dysplasie broncho-pulmonaire	0,7 %	0,4 %	1,00	0,55-1,83	0,994
Grossesse ^{a,b}	3,0 %	2,0 %	1,07	0,43-2,68	0,888
Prématuré ^{a,c}	8,4 %	10,9 %	1,31	0,91-1,89	0,149
Syndrome polymalformatif ^c	0,4 %	0,3 %	0,89	0,11-7,01	0,913
Admission antérieur pour bronchiolite ^c	6,6 %	4,9 %	0,75	0,45-1,28	0,292

aOR = Rapport de cotes ajusté, corrigé pour l'âge catégorisé en 0-4 ; 5-17 ; 18-64 ; 65-79 ; 80+

95% CI = Intervalle de confiance à 95 %

^a Comorbidités dont la présence doit obligatoirement être rapportée

^b N = uniquement les femmes âgées de 18-64 ans

^c N = uniquement les enfants âgés de 0-4 ans

3.2.4. Évolution de la maladie

Sans correction, la durée de séjour était en moyenne plus longue chez les patients répondant uniquement à la nouvelle définition de cas, mais après correction pour l'âge, la moyenne est significativement plus courte (coefficient de régression = -0,43) et la médiane ne diffère plus (coefficient de régression = 0) (Tableau 7). Les patients répondant uniquement à la nouvelle définition de cas sont nettement plus souvent admis aux soins intensifs, même après correction pour l'âge. Ce phénomène est observé pour les quatre pathogènes, bien qu'il ne soit statistiquement significatif que chez les patients atteints de VRS (voir le tableau supplémentaire par pathogène en annexe). Par catégorie d'âge, la différence est la plus marquée chez les jeunes enfants et très faible chez les personnes âgées (voir le tableau supplémentaire par groupe d'âge en annexe).

Chez les patients répondant uniquement à la nouvelle définition de cas, des complications sont rapportées beaucoup moins fréquemment que chez ceux répondant à l'ancienne définition, après correction pour l'âge.

Les complications significativement moins fréquentes sont la pneumonie, la septicémie, les surinfections non pulmonaires, les troubles hépatiques, le choc et les complications dermatologiques. En revanche, les complications cardiovasculaires sont significativement plus fréquentes. Ce schéma est observé pour les quatre pathogènes, bien qu'il soit parfois moins prononcé et statistiquement significatif uniquement pour la pneumonie chez les patients atteints de VRS et de hMPV.

Les patients répondant uniquement à la nouvelle définition de cas présentent un taux de mortalité nettement plus élevé que ceux répondant à l'ancienne définition. Ce taux plus élevé est observé dans toutes les classes d'âge adultes, mais surtout chez les personnes de 65 ans et plus. Il est également observé chez les patients atteints de grippe, de VRS et de COVID-19, bien que moins marqué pour la grippe et le COVID-19, et jamais statistiquement significatif en raison du faible nombre de cas. Après correction pour l'âge, le taux de mortalité chez les patients atteints de hMPV ne diffère plus entre l'ancienne et la nouvelle définition de cas uniquement.

Tableau 7: Différences dans l'évolution de la maladie entre les patients SARI selon l'ancienne définition de cas et uniquement la nouvelle définition de cas

	Ancienne définition de cas (N=7966)	Uniquement nouvelle définition de cas (N=4135)	aRegr- coef/ aOR	95 % CI	Valeur p
<i>aRC</i>					
Durée de séjour (moyenne en jours)	7,3	9,0	-0,43	-0,81 - -0,04	0,031
Durée de séjour (médiane et Q25-Q75)	4 (2-8)	6 (3-11)	0	-0,23-0,23	1,000
<i>aOR</i>					
Admission en soins intensifs	10,0 %	13,7 %	1,18	1,05-1,33	0,007
ECMO	0,2 %	0,2 %	0,96	0,35-2,65	0,936
Assistance respiratoire invasive	3,0 %	3,8 %	1,01	0,80-1,28	0,908
Complications					
Au moins 1 complication	36,7 %	36,6 %	0,70	0,64-0,76	<0,001
Pneumonie ^a	19,5 %	18,8 %	0,68	0,62-0,75	<0,001
Lésion rénale aiguë ^a	8,1 %	11,5 %	0,90	0,79-1,02	0,102
Cardio-vasculaires	5,2 %	9,9 %	1,21	1,04-1,41	0,016
SDRA ^a	4,2 %	5,3 %	1,10	0,91-1,32	0,316
Septicémie	3,7 %	2,3 %	0,41	0,32-0,53	<0,001
Surinfection non-pulmonaire	1,7 %	0,7 %	0,30	0,19-0,48	<0,001
Dysfonctionnement hépatique	1,5 %	0,9 %	0,43	0,28-0,64	<0,001
Choc	1,0 %	0,7 %	0,50	0,31-0,82	0,006
Défaillance multi-viscérale (MOF)	0,6 %	0,7 %	0,80	0,47-1,34	0,391
Encéphalite	0,5 %	0,3 %	0,62	0,31-1,27	0,191
Thromboemboliques	0,8 %	1,3 %	1,16	0,78-1,72	0,478
Dermatologiques	0,8 %	0,3 %	0,42	0,20-0,87	0,020
Hémorragie	0,5 %	0,4 %	0,58	0,31-1,09	0,089
Convulsions fébriles	0,5 %	0,2 %	1,29	0,50-3,34	0,601
Syndrome Guillain Barré	<0,06 %	0,0 %	-	-	-
Issue clinique^b					
	N=7280	N=3829			
Guéri	90,5 %	85,4 %	0,91	0,81-1,03	0,157
Décédé	5,0 %	10,2 %	1,30	1,12-1,52	0,001
Séquelles	4,5 %	4,5 %	0,81	0,66-0,99	0,035
SARI avec complications^c	15,6 %	21,8 %	1,13	1,02-1,27	0,026

aRC = Coefficient de régression ajusté, corrigé pour l'âge catégorisé en 0-4 ; 5-17 ; 18-64 ; 65-79 ; 80+

aOR = Rapport de cotes ajusté, corrigé pour l'âge catégorisé en 0-4 ; 5-17 ; 18-64 ; 65-79 ; 80+

95% CI = Intervalle de confiance à 95 %

^a Complications dont la présence doit obligatoirement être rapportée

^b Les patients transférés ou dont l'issue était inconnue ne sont pas inclus

^c Un cas de SARI est considéré comme compliqué en présence d'un SDRA, d'une admission en soins intensifs, d'un traitement par ECMO, d'une ventilation invasive ou d'un décès

4. DISCUSSION

Dans ce rapport, les données des patients SARI hospitalisés entre le 13 novembre 2023 et le 5 septembre 2025 ont été analysées afin d'examiner comment l'introduction d'une nouvelle définition de cas a influencé la surveillance SARI, et dans quelle mesure le profil des patients répondant à la nouvelle définition de cas, mais pas à l'ancienne, diffère de celui des patients répondant à l'ancienne définition.

4.1. Différences de profil

La différence la plus marquante entre les deux définitions de cas concerne l'âge. L'adaptation principale de la nouvelle définition, par rapport à l'ancienne, est que la fièvre (ou des antécédents de fièvre) n'est plus une condition obligatoire. Les patients supplémentaires désormais classés comme SARI, mais qui ne l'étaient pas auparavant, sont donc principalement des patients présentant deux symptômes respiratoires sévères (toux, signes de détresse respiratoire et/ou auscultation pulmonaire anormale, et chez les enfants également apnée ou cyanose), mais sans fièvre. Cette situation devient plus fréquente avec l'âge (12,13). En conséquence, la population SARI est désormais nettement plus âgée qu'auparavant. Cela vaut pour la population SARI dans son ensemble, mais aussi pour les principaux pathogènes suivis dans le cadre de la surveillance SARI. Les patients SARI atteints de grippe, de VRS, de COVID-19 ou de hMPV sont nettement plus âgés selon la nouvelle définition, car la fièvre est moins fréquente avec l'avancée en âge pour toutes ces infections (14–17).

Une exception concerne les infections à VRS chez les très jeunes enfants (jusqu'à 6 mois), dont la proportion n'a pas diminué et a même légèrement augmenté. Alors que la fièvre est plus fréquente chez les enfants que chez les adultes, cela ne s'applique pas aux très jeunes enfants atteints de VRS, qui, surtout avant l'âge de 3 mois, présentent souvent une infection sans fièvre (7,8,10). Dans notre analyse également, les enfants de 0 à 3 mois atteints de VRS présentaient nettement moins de fièvre que les enfants plus âgés.

Il est également frappant que les patients ne répondant pas à l'ancienne définition, mais bien à la nouvelle, présentent un tableau clinique plus sévère à l'admission. Les symptômes indiquant une maladie grave — tels qu'une auscultation pulmonaire anormale, des difficultés respiratoires, une respiration sifflante, une tachypnée ou une dépendance à l'oxygène — étaient nettement plus fréquents chez eux. Les symptômes suggérant une infection moins sévère, comme la rhinite, le mal de gorge ou les nausées, étaient moins fréquents. Cela s'explique en partie par la différence d'âge, mais même après correction pour l'âge, les écarts restent importants. Les jeunes enfants présentaient également beaucoup plus souvent de la cyanose, de l'apnée, un battement des ailes du nez, des geignements expiratoires, des rétractions intercostales subvertébrales, de l'hypopnée et un balancement thoraco-abdominal. Ce phénomène est observé chez les patients atteints de grippe, de VRS, de COVID-19 et de hMPV.

Il semble logique que l'auscultation anormale, ainsi que la cyanose et l'apnée chez les jeunes enfants, soient plus fréquentes dans la nouvelle définition, puisqu'elles y sont explicitement mentionnées comme critères possibles. Cela signifie toutefois que ces symptômes étaient moins fréquents chez les patients répondant à l'ancienne définition, ce qui suggère que la fièvre n'est pas un bon indicateur de la gravité d'une infection respiratoire chez les patients hospitalisés. Ce constat a également été rapporté dans plusieurs autres études (18–20). Une explication possible est que les patients sans fièvre tardent davantage à consulter, ce qui retarde le début du traitement. Certains symptômes graves — tels que le bronchospasme, l'œdème pulmonaire, les altérations de la conscience et les convulsions — étaient en revanche moins fréquents dans la nouvelle définition, probablement parce qu'ils s'accompagnent presque toujours de fièvre. Le tableau clinique plus sévère des patients répondant uniquement à la nouvelle définition se traduit, chez les jeunes enfants et les jeunes adultes, par une admission plus fréquente en soins intensifs, et chez les personnes âgées, par un taux de mortalité plus élevé.

Les comorbidités différaient également entre les définitions. Les patients répondant uniquement à la nouvelle définition présentaient nettement plus souvent une affection sous-jacente, en particulier des maladies respiratoires et cardiaques chroniques. Cela est vrai pour tous les pathogènes et dans toutes les classes

d'âge, bien que plus marqué chez les jeunes adultes. Cela pourrait indiquer que ces affections sous-jacentes constituent un facteur de risque d'infections sévères ne s'accompagnant pas de fièvre.

4.2. Impact sur la surveillance SARI

La principale raison de l'introduction de la nouvelle définition de cas était d'améliorer l'identification des infections respiratoires sévères causées par le VRS ou le COVID-19, en particulier chez les jeunes enfants. L'application des nouveaux critères a entraîné une augmentation d'environ 50 % du nombre de cas SARI enregistrés. Au sein de cette hausse, davantage de cas de VRS et de COVID-19 ont effectivement été détectés que de cas de grippe, ce qui indique que la nouvelle définition de cas permet de mieux détecter ces deux infections. Lorsqu'on analyse les résultats par catégorie d'âge, il apparaît que ce sont surtout les cas de VRS qui sont plus fréquemment captés. Cela concorde avec d'autres études montrant que les adultes atteints de VRS présentent plus souvent une infection sans fièvre que les patients grippés (21,22). Cette augmentation se manifeste principalement chez les adultes, en particulier chez les personnes âgées, tandis que la hausse reste limitée chez les enfants.

La nouvelle définition de cas semble donc moins efficace pour détecter des cas supplémentaires chez les enfants, probablement parce qu'ils présentent généralement de la fièvre. Une exception importante concerne toutefois les très jeunes nourrissons de moins de 6 mois. Étant donné qu'ils constituent un groupe cible important — car ils sont vulnérables aux infections sévères à VRS et représentent environ un quart de tous les cas de VRS hospitalisés — on peut considérer que la nouvelle définition de cas a également permis de mieux détecter les infections à VRS chez les jeunes enfants.

L'augmentation du nombre de cas rapportés s'accompagne cependant d'une perte de spécificité. Le taux de positivité parmi les nouveaux cas SARI était nettement plus faible que parmi les anciens cas SARI, et ce pour tous les pathogènes testés. Cela suggère que les infections respiratoires sévères sans fièvre sont plus souvent causées par d'autres pathogènes que ceux inclus dans le panel de tests de la surveillance SARI.

Le tableau clinique plus sévère des cas SARI supplémentaires détectés influence l'indicateur « SARI avec complications ». Un cas SARI est considéré comme compliqué en présence d'un SDRA, d'une admission en soins intensifs, d'un traitement par ECMO, d'une ventilation invasive ou d'un décès. Ces indicateurs étaient plus fréquents parmi les cas identifiés selon la nouvelle définition de cas, ce qui entraîne une augmentation plus marquée de l'indicateur « SARI avec complications » que de l'indicateur SARI global.

4.3. Limitations de l'étude

Les données utilisées proviennent d'un système de surveillance de routine dans lequel les hôpitaux collectent et transmettent eux-mêmes les informations. La qualité des données dépend donc de l'engagement du personnel hospitalier et est sujette à des erreurs telles que des rapports incomplets et des classifications erronées. En 2023, le système de surveillance a été profondément révisé et la qualité s'est nettement améliorée. Nous estimons donc que la qualité est suffisante.

Dans la surveillance SARI, certaines variables doivent obligatoirement être rapportées, tandis que d'autres sont facultatives. La prévalence des variables non obligatoires doit dès lors être interprétée avec prudence. Toutefois, le pourcentage de données manquantes était comparable entre les définitions de cas et n'a donc pas influencé la comparaison.

5. CONCLUSION

La nouvelle définition de cas permet d'identifier un nombre substantiel de cas supplémentaires des principales infections virales respiratoires, et en particulier des cas supplémentaires de VRS, y compris chez les jeunes enfants. Le profil de ces cas supplémentaires détectés diffère toutefois sensiblement de celui des

cas rapportés selon l'ancienne définition de cas. Il s'agit principalement d'infections plus graves chez des patients plus âgés, qui ne s'accompagnent pas de fièvre.

RÉFÉRENCES

1. Moriyama M, Hugentobler WJ, Iwasaki A. Seasonality of Respiratory Viral Infections. *Annu Rev Virol.* 2020 Sep 29;7(1):83–101. doi:10.1146/annurev-virology-012420-022445 PubMed PMID: 32196426.
2. Fitzner J, Qasmieh S, Mounts AW, Alexander B, Besselaar T, Briand S, et al. Revision of clinical case definitions: influenza-like illness and severe acute respiratory infection. *Bull World Health Organ.* 2018 Feb 1;96(2):122–8. doi:10.2471/BLT.17.194514 PubMed PMID: 29403115; PubMed Central PMCID: PMC5791775.
3. WHO global technical consultation: global standards and tools for influenza surveillance [Internet]. World Health Organization; 2011. Available from: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/bca0b4cb-4be3-45d7-8b50-da7cf0c319a1/content>
4. Makokha C, Mott J, Njuguna HN, Khagayi S, Verani JR, Nyawanda B, et al. Comparison of severe acute respiratory illness (sari) and clinical pneumonia case definitions for the detection of influenza virus infections among hospitalized patients, western Kenya, 2009–2013. *Influenza Other Respir Viruses.* 2016 Jul;10(4):333–9. doi:10.1111/irv.12382 PubMed PMID: 27219455; PubMed Central PMCID: PMC4910169.
5. Jones AH, Ampofo W, Akuffo R, Doman B, Duplessis C, Amankwa JA, et al. Sentinel surveillance for influenza among severe acute respiratory infection and acute febrile illness inpatients at three hospitals in Ghana. *Influenza Other Respir Viruses.* 2016 Sep;10(5):367–74. doi:10.1111/irv.12397 PubMed PMID: 27239956; PubMed Central PMCID: PMC4947945.
6. Amini R, Gilca R, Douville-Fradet M, Boulianne N, De Serres G. Evaluation of the New World Health Organization Case Definition of Severe Acute Respiratory Infection for Influenza Surveillance During the Peak Weeks of Two Influenza Seasons in Quebec, Canada. *J Pediatric Infect Dis Soc.* 2017 Sep 1;6(3):297–300. doi:10.1093/jpids/piw044 PubMed PMID: 27496537.
7. Rha B, Dahl RM, Moyes J, Binder AM, Tempia S, Walaza S, et al. Performance of Surveillance Case Definitions in Detecting Respiratory Syncytial Virus Infection Among Young Children Hospitalized With Severe Respiratory Illness–South Africa, 2009–2014. *J Pediatric Infect Dis Soc.* 2019 Sep 25;8(4):325–33. doi:10.1093/jpids/piy055 PubMed PMID: 29931284.
8. Klink T, Rankin DA, Piya B, Spieker AJ, Faouri S, Shehabi A, et al. Evaluating the diagnostic accuracy of the WHO Severe Acute Respiratory Infection (SARI) criteria in Middle Eastern children under two years over three respiratory seasons. *PLoS One.* 2020;15(4):e0232188. doi:10.1371/journal.pone.0232188 PubMed PMID: 32353012; PubMed Central PMCID: PMC7192447.
9. Subissi L, Bossuyt N, Reynders M, Gérard M, Dauby N, Bourgeois M, et al. Capturing respiratory syncytial virus season in Belgium using the influenza severe acute respiratory infection surveillance network, season 2018/19. *Euro Surveill.* 2020 Oct;25(39):1900627. doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.39.1900627 PubMed PMID: 33006303; PubMed Central PMCID: PMC7531071.
10. Hirve S, Crawford N, Palekar R, Zhang W, WHO VRS surveillance Group. Clinical characteristics, predictors, and performance of case definition–Interim results from the WHO global respiratory syncytial virus surveillance pilot. *Influenza Other Respir Viruses.* 2020 Nov;14(6):647–57. doi:10.1111/irv.12688 PubMed PMID: 31670892; PubMed Central PMCID: PMC7578293.
11. Case definitions [Internet]. [cited 2025 Dec 18]. Available from: <https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/global-respiratory-syncytial-virus-surveillance/case-definitions>

12. Norman DC. Fever in the elderly. *Clin Infect Dis*. 2000 Jul;31(1):148–51. doi:10.1086/313896 PubMed PMID: 10913413.
13. Roghmann MC, Warner J, Mackowiak PA. The relationship between age and fever magnitude. *Am J Med Sci*. 2001 Aug;322(2):68–70. doi:10.1097/00000441-200108000-00003 PubMed PMID: 11523629.
14. Falsey AR, Baran A, Walsh EE. Should clinical case definitions of influenza in hospitalized older adults include fever? *Influenza Other Respir Viruses*. 2015 Aug;9 Suppl 1(Suppl 1):23–9. doi:10.1111/irv.12316 PubMed PMID: 26256292; PubMed Central PMCID: PMC4549099.
15. Van Son CR, Eti DU. Screening for COVID-19 in Older Adults: Pulse Oximeter vs. Temperature. *Front Med (Lausanne)*. 2021;8:660886. doi:10.3389/fmed.2021.660886 PubMed PMID: 33937297; PubMed Central PMCID: PMC8079646.
16. Sachar M, Bayer T, DeVone F, Halladay C, McConeghy K, Elhamamsy S, et al. The effect of age on fever response among nursing home residents with SARS-COV-2 infection. *Aging Clin Exp Res*. 2022 Mar;34(3):691–3. doi:10.1007/s40520-021-02048-x PubMed PMID: 35025096; PubMed Central PMCID: PMC8757396.
17. Rozenbaum MH, Begier E, Kurosky SK, Whelan J, Bem D, Pouwels KB, et al. Incidence of Respiratory Syncytial Virus Infection in Older Adults: Limitations of Current Data. *Infect Dis Ther*. 2023 Jun;12(6):1487–504. doi:10.1007/s40121-023-00802-4 PubMed PMID: 37310617; PubMed Central PMCID: PMC10262134.
18. Sopirala MM, Haas DM, Ali NA, Mangino JE, Pan X, Turner AN. Effect of fever on hospital presentation, diagnosis, and treatment in patients with H1N1/09 influenza. *J Hosp Med*. 2013 Jan;8(1):20–4. doi:10.1002/jhm.1981 PubMed PMID: 23024066; PubMed Central PMCID: PMC4271823.
19. Smith BJ, Price DJ, Johnson D, Garbutt B, Thompson M, Irving LB, et al. Influenza With and Without Fever: Clinical Predictors and Impact on Outcomes in Patients Requiring Hospitalization. *Open Forum Infect Dis*. 2020 Jul;7(7):ofaa268. doi:10.1093/ofid/ofaa268 PubMed PMID: 33123614; PubMed Central PMCID: PMC7580166.
20. Henriksen DP, Havshøj U, Pedersen PB, Laursen CB, Jensen HK, Brabrand M, et al. Hospitalized acute patients with fever and severe infection have lower mortality than patients with hypo- or normothermia: a follow-up study. *QJM*. 2016 Jul;109(7):473–9. doi:10.1093/qjmed/hcw022 PubMed PMID: 26961550.
21. Wildenbeest JG, Lowe DM, Standing JF, Butler CC. Respiratory syncytial virus infections in adults: a narrative review. *Lancet Respir Med*. 2024 Oct;12(10):822–36. doi:10.1016/S2213-2600(24)00255-8 PubMed PMID: 39265602.
22. Michelin L, Bellei N, Ferreira da Costa Gomes M, Raboni SM, Kairalla M, Correa RA, et al. Respiratory syncytial virus: challenges in diagnosis and impact on the elderly: Recommendations from a multidisciplinary panel. *Hum Vaccin Immunother*. 2024 Dec 31;20(1):2388943. doi:10.1080/21645515.2024.2388943 PubMed PMID: 39161095; PubMed Central PMCID: PMC11340750.

ANNEXE: TABLEAU AVEC ANALYSES COMPLÉMENTAIRES

Tableau 8: Différences de symptômes entre les patients SARI selon l'ancienne définition de cas et uniquement la nouvelle définition de cas, par pathogène

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	aOR*	95 % CI	Valeur p
Grippe	N=1212	N=310			
Fièvre	86,9 %	3,2 %	0,006	0,003-0,011	<0,001
Historique de fièvre	59,2 %	1,7 %	0,014	0,006-0,034	<0,001
Fièvre et/ou historique de fièvre	100,0 %	3,2 %	-	-	-
Toux	91,7 %	86,7 %	0,61	0,42-0,91	<0,001
Auscultation pulmonaire anormale	59,0 %	85,2 %	2,58	1,82-3,68	<0,001
Problèmes respiratoires	59,7 %	84,5 %	2,00	1,40-2,83	<0,001
Cyanose	3,5 %	0,0 %	-	-	-
Apnée	2,0 %	10,0 %	5,31	0,57-49,14	0,142
Anorexie/problèmes nutritionnels	49,8 %	28,3 %	0,47	0,35-0,63	<0,001
Dépendance à l'oxygène	54,3 %	77,6 %	1,48	1,08-2,03	0,016
Rhinite	38,1 %	13,9 %	0,50	0,31-0,82	0,006
Mal de gorge	23,8 %	6,9 %	0,27	0,14-0,50	<0,001
Vomissements	25,5 %	11,5 %	0,62	0,38-1,01	0,055
Malaise	59,1 %	41,4 %	0,39	0,28-0,55	<0,001
Myalgies	30,2 %	15,1 %	0,34	0,22-0,53	<0,001
Nausée	21,9 %	13,1 %	0,56	0,35-0,90	0,017
Diarrhée	20,8 %	14,1 %	0,78	0,49-1,24	0,289
Fatigue	56,7 %	40,9 %	0,47	0,33-0,66	<0,001
Otite	5,6 %	0,0 %	-	-	-
Douleur thoracique	16,6 %	16,1 %	0,75	0,47-1,18	0,207
Bronchospasme	7,4 %	6,5 %	0,65	0,32-1,35	0,248
Œdème pulmonaire	3,8 %	<1,6 %	0,19	0,04-0,82	0,026
Conscience altérée	7,5 %	7,4 %	0,98	0,21-4,58	0,977
Convulsions	5,8 %	4,4 %	1,41	0,17-11,59	0,748
Respiration sifflante	21,0 %	43,3 %	1,50	0,64-3,50	0,354
Battement des ailes du nez	2,0 %	0,0 %	-	-	-
Geignement expiratoire	8,9 %	0,0 %	-	-	-
Rétractions intercostales subvertébrales	5,0 %	16,7 %	4,61	0,48-44,53	0,186
Balancement thoraco-abdominal	2,0 %	0,0 %	-	-	-
Hypotonie	5,9 %	0,0 %	-	-	-
Hypopnée	0,0 %	0,0 %	-	-	-
Tachypnée	11,7 %	16,7 %	1,54	0,17-13,81	0,699
Confusion	23,4 %	24,3 %	0,82	0,53-1,25	0,350
Chute soudaine	15,6 %	18,0 %	1,02	0,63-1,64	0,939
RSV	N=784	N=254			
Fièvre	84,7 %	2,4 %	0,005	0,002-0,011	<0,001
Historique de fièvre	61,2 %	2,5 %	0,019	0,008-0,043	<0,001
Fièvre et/ou historique de fièvre	100,0 %	3,2 %	-	-	-
Toux	94,2 %	87,3 %	0,61	0,36-1,01	0,057
Auscultation pulmonaire anormale	73,2 %	83,3 %	1,46	0,99-2,15	0,056
Problèmes respiratoires	69,9 %	87,0 %	2,23	1,48-3,38	<0,001
Cyanose	5,5 %	12,1 %	2,42	1,15-5,10	0,020
Apnée	1,9 %	3,4 %	1,79	0,48-6,76	0,389
Anorexie/problèmes nutritionnels	56,6 %	34,6 %	0,52	0,37-0,71	<0,001
Dépendance à l'oxygène	57,5 %	69,6 %	1,00	0,71-1,41	0,987
Rhinite	65,9 %	40,1 %	0,61	0,39-0,93	0,023
Mal de gorge	15,2 %	6,5 %	0,36	0,17-0,74	0,005
Vomissements	32,1 %	15,1 %	0,54	0,33-0,87	0,012
Malaise	41,3 %	28,8 %	0,39	0,26-0,61	<0,001
Myalgies	8,3 %	7,6 %	0,45	0,21-0,95	0,036
Nausée	11,6 %	8,7 %	0,59	0,31-1,14	0,116

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	aOR*	95 % CI	Valeur p
Diarrhée	22,2 %	5,9 %	0,24	0,12-0,48	<0,001
Fatigue	43,1 %	29,1 %	0,45	0,29-0,68	<0,001
Otite	8,4 %	2,0 %	0,20	0,05-0,83	0,027
Douleur thoracique	7,3 %	13,9 %	1,06	0,57-1,99	0,850
Bronchospasme	17,1 %	14,3 %	0,85	0,49-1,50	0,582
OEdème pulmonaire	2,3 %	2,1 %	0,49	0,12-1,91	0,303
Conscience altérée	4,1 %	2,1 %	0,30	0,06-1,47	0,137
Convulsions	1,8 %	<2,0 %	0,59	0,07-4,69	0,615
Respiration sifflante	40,8 %	29,1 %	0,54	0,34-0,87	0,012
Battement des ailes du nez	11,4 %	15,4 %	1,42	0,66-3,07	0,369
Geignement expiratoire	12,0 %	15,9 %	1,36	0,63-2,95	0,431
Rétractions intercostales subvertébrales	33,5 %	55,0 %	2,47	1,39-4,38	0,002
Balancement thoraco-abdominal	9,8 %	8,5 %	1,05	0,41-2,71	0,919
Hypotonie	2,6 %	<2,0 %	0,58	0,07-4,83	0,617
Hypopnée	2,2 %	3,2 %	1,38	0,27-7,02	0,696
Tachypnée	32,7 %	33,3 %	1,04	0,57-1,89	0,906
Confusion	21,1 %	14,0 %	0,51	0,25-1,04	0,064
Chute soudaine	17,1 %	14,4 %	0,83	0,39-1,76	0,626
COVID-19	N=614	N=240			
Fièvre	81,7 %	10,4 %	0,027	0,017-0,043	<0,001
Historique de fièvre	59,5 %	4,9 %	0,035	0,018-0,065	<0,001
Fièvre et/ou historique de fièvre	100,0 %	11,3 %	-	-	-
Toux	84,4 %	71,6 %	0,51	0,36-0,74	<0,001
Auscultation pulmonaire anormale	52,2 %	85,2 %	4,39	2,93-6,58	<0,001
Problèmes respiratoires	58,1 %	81,3 %	2,48	1,69-3,65	<0,001
Cyanose	1,8 %	16,7 %	21	1,75-252-41	0,016
Apnée	1,7 %	8,3 %	4,73	0,40-56,43	0,220
Anorexie/problèmes nutritionnels	49,6 %	29,1 %	0,38	0,27-0,53	<0,001
Dépendance à l'oxygène	46,3 %	70,2 %	2,18	1,55-3,07	<0,001
Rhinite	39,0 %	12,0 %	0,30	0,17-0,53	<0,001
Mal de gorge	30,5 %	9,7 %	0,21	0,12-0,39	<0,001
Vomissements	15,7 %	7,7 %	0,51	0,27-0,99	0,047
Malaise	65,1 %	38,5 %	0,27	0,18-0,40	<0,001
Myalgies	27,6 %	7,5 %	0,16	0,08-0,32	<0,001
Nausée	13,5 %	13,6 %	0,91	0,53-1,57	0,736
Diarrhée	18,6 %	9,9 %	0,52	0,28-0,94	0,030
Fatigue	61,9 %	33,8 %	0,26	0,17-0,39	<0,001
Otite	0,9 %	<2,1 %	3,00	0,23-38,28	0,396
Douleur thoracique	12,4 %	14,9 %	1,03	0,59-1,79	0,913
Bronchospasme	8,7 %	<2,1 %	0,07	0,01-0,50	0,008
OEdème pulmonaire	3,6 %	<2,1 %	0,33	0,07-1,48	0,148
Conscience altérée	5,2 %	4,2 %	0,51	0,05-4,99	0,564
Convulsions	1,6 %	0,0 %	-	-	-
Respiration sifflante	10,6 %	37,5 %	3,26	1,08-9,79	0,035
Battement des ailes du nez	1,3 %	0,0 %	-	-	-
Geignement expiratoire	10,8 %	0,0 %	-	-	-
Rétractions intercostales subvertébrales	5,4 %	0,0 %	-	-	-
Balancement thoraco-abdominal	1,3 %	0,0 %	-	-	-
Hypotonie	4,1 %	0,0 %	-	-	-
Hypopnée	0,0 %	25,0 %	-	-	-
Tachypnée	6,8 %	0,0 %	-	-	-
Confusion	32,6 %	14,9 %	0,34	0,20-0,58	<0,001
Chute soudaine	27,0 %	19,6 %	0,64	0,39-1,06	0,081
hMPV	N=415	N=114			
Fièvre	86,7 %	<4,4 %	0,006	0,002-0,016	<0,001
Historique de fièvre	69,9 %	<4,4 %	0,002	0,006-0,035	<0,001
Fièvre et/ou historique de fièvre	100,0 %	<4,4 %	-	-	-
Toux	92,9 %	82,5 %	0,36	0,19-0,66	0,001
Auscultation pulmonaire anormale	80,5 %	85,8 %	1,47	0,82-2,64	0,193
Problèmes respiratoires	74,8 %	89,4 %	2,83	1,49-5,73	0,001

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	aOR*	95 % CI	Valeur p
Cyanose	5,8 %	10,0 %	1,81	0,37-8,70	0,462
Apnée	3,4 %	10,0 %	3,14	0,61-16,26	0,172
Anorexie/problèmes nutritionnels	58,7 %	24,5 %	0,23	0,14-0,37	<0,001
Dépendance à l'oxygène	60,4 %	71,2 %	1,62	1,02-2,56	0,039
Rhinite	58,3 %	20,3 %	0,17	0,09-0,33	<0,001
Mal de gorge	19,0 %	<4,4 %	0,14	0,03-0,57	0,007
Vomissements	32,5 %	10,8 %	0,25	0,12-0,54	<0,001
Malaise	49,2 %	27,9 %	0,40	0,22-0,72	0,002
Myalgies	13,6 %	0,0 %	-	-	-
Nausée	13,2 %	8,2 %	0,59	0,24-1,47	0,256
Diarrhée	22,7 %	10,8 %	0,41	0,19-0,90	0,026
Fatigue	53,2 %	34,3 %	0,46	0,26-0,81	0,007
Otite	7,9 %	<4,4 %	0,33	0,08-1,41	0,134
Douleur thoracique	9,7 %	12,7 %	1,35	0,60-3,06	0,466
Bronchospasme	17,4 %	8,8 %	0,46	0,17-1,22	0,117
Œdème pulmonaire	2,8 %	5,4 %	2,00	0,48-8,26	0,338
Conscience altérée	2,9 %	0,0 %	-	-	-
Convulsions	4,3 %	<4,4 %	0,83	0,10-6,79	0,860
Respiration sifflante	41,3 %	45,5 %	1,19	0,57-2,46	0,645
Battement des ailes du nez	10,4 %	0,0 %	-	-	-
Geignement expiratoire	11,9 %	0,0 %	-	-	-
Rétractions intercostales subvertébrales	26,6 %	7,7 %	0,23	0,29-1,83	0,165
Balancement thoraco-abdominal	10,1 %	0,0 %	-	-	-
Hypotonie	10,4 %	0,0 %	-	-	-
Hypopnée	<1,2 %	7,1 %	10,1	0,60-169,93	0,109
Tachypnée	32,6 %	15,4 %	0,38	0,08-1,77	0,215
Confusion	19,8 %	12,7 %	0,59	0,23-1,50	0,268
Chute soudaine	9,1 %	11,1 %	1,25	0,42-3,72	0,688

*Rapport de cotes ajusté, corrigé pour l'âge catégorisé en 0-4 ; 5-17 ; 18-64 ; 65-79 ; 80+

Tableau 9: Différences de symptômes entre les patients SARI selon l'ancienne définition de cas et uniquement la nouvelle définition de cas, par catégorie d'âge

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	aOR*	95 % CI	Valeur p
0-5 ans	N=2794	N=361			
Fièvre	89,1 %	14,7 %	0,021	0,015-0,029	<0,001
Historique de fièvre	65,7 %	9,7 %	0,06	0,04-0,08	<0,001
Fièvre et/ou historique de fièvre	100,0 %	16,1 %	1,00	-	-
Toux	95,1 %	76,5 %	0,17	0,13-0,23	<0,001
Auscultation pulmonaire anormale	57,1 %	81,0 %	3,19	2,42-4,21	<0,001
Problèmes respiratoires	50,9 %	71,9 %	2,46	1,92-3,14	<0,001
Cyanose	5,3 %	11,7 %	2,33	1,59-3,42	<0,001
Apnée	2,8 %	9,3 %	3,37	2,15-5,29	<0,001
Anorexie/problèmes nutritionnels	58,1 %	45,7 %	0,61	0,49-0,78	<0,001
Dépendance à l'oxygène	35,1 %	37,2 %	1,12	0,89-1,42	0,328
Rhinite	78,7 %	61,9 %	0,43	0,32-0,57	<0,001
Mal de gorge	20,1 %	8,8 %	0,40	0,24-0,65	<0,001
Vomissements	37,5 %	21,8 %	0,47	0,34-0,65	<0,001
Malaise	39,5 %	23,0 %	0,46	0,33-0,65	<0,001
Myalgies	9,7 %	4,8 %	0,49	0,25-0,95	0,035
Nausée	26,0 %	13,2 %	0,43	0,29-0,63	<0,001
Diarrhée	44,1 %	28,2 %	0,51	0,37-0,70	<0,001
Fatigue	11,1 %	4,6 %	0,39	0,21-0,72	0,003
Otite	10,4 %	14,9 %	1,52	0,98-2,35	0,059
Conscience altérée	4,3 %	4,3 %	1,02	0,57-1,82	0,948
Convulsions	4,5 %	2,7 %	0,61	0,30-1,23	0,167
Respiration sifflante	27,4 %	33,1 %	1,33	1,04-1,69	0,022
Battement des ailes du nez	9,5 %	11,7 %	1,25	0,79-1,99	0,339
Geignement expiratoire	12,2 %	14,5 %	1,18	0,78-1,80	0,435
Balancement thoraco-abdominal	5,6 %	8,2 %	1,49	0,85-2,62	0,167
Rétractions intercostales subvertébrales	21,2 %	38,0 %	2,23	1,62-3,07	<0,001
Hypotonie	3,1 %	2,9 %	0,97	0,41-2,32	0,948
Hypopnée	1,4 %	3,9 %	2,85	1,22-6,67	0,016
Tachypnée	22,3 %	28,7 %	1,40	0,997-1,96	0,052
6-64 ans	N=1861	N=862			
Fièvre	80,7 %	3,6 %	0,010	0,007-0,014	<0,001
Historique de fièvre	63,7 %	2,2 %	0,014	0,008-0,022	<0,001
Fièvre et/ou historique de fièvre	100,0 %	4,0 %	1,00	-	-
Toux	88,0 %	80,6 %	0,64	0,51-0,80	<0,001
Auscultation pulmonaire anormale	62,5 %	83,9 %	2,80	2,26-3,46	<0,001
Problèmes respiratoires	73,3 %	90,8 %	3,00	2,31-3,89	<0,001
Anorexie	40,5 %	16,4 %	0,32	0,26-0,40	<0,001
Dépendance à l'oxygène	60,0 %	81,2 %	2,40	1,95-2,95	<0,001
Rhinite	30,0 %	10,8 %	0,38	0,28-0,53	<0,001
Mal de gorge	26,9 %	9,1 %	0,32	0,23-0,46	<0,001
Vomissements	23,8 %	9,2 %	0,41	0,30-0,57	<0,001
Malaise	55,3 %	21,8 %	0,24	0,19-0,31	<0,001
Myalgies	31,8 %	9,6 %	0,23	0,17-0,33	<0,001
Nausée	24,6 %	8,4 %	0,31	0,22-0,43	<0,001
Diarrhée	16,4 %	9,5 %	0,51	0,36-0,71	<0,001
Fatigue	52,0 %	25,5 %	0,33	0,26-0,42	<0,001
Otite	1,6 %	0,7 %	0,73	0,24-2,23	0,583
Douleur thoracique	28,2 %	27,5 %	0,99	0,78-1,25	0,906
Bronchospasme	9,4 %	9,0 %	0,98	0,64-1,49	0,914
Conscience altérée	11,3 %	2,7 %	0,17	0,04-0,73	0,017
OEdème pulmonaire	0,9 %	2,4 %	2,37	0,87-6,45	0,092
Convulsions	5,1 %	0,0 %	-	-	-
Respiration sifflante	35,9 %	65,8 %	2,94	1,90-4,53	<0,001
Tachypnée	10,7 %	38,5 %	5,13	1,46-18,05	0,011
Confusion	6,5 %	4,0 %	0,52	0,30-0,91	0,023
Chute soudaine	4,6 %	3,9 %	0,66	0,37-1,19	0,168

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	aOR*	95 % CI	Valeur p
65+ ans	n=3311	n=2912			
Fièvre	81,2 %	3,5 %	0,008	0,007-0,010	<0,001
Historique de fièvre	55,6 %	1,2 %	0,010	0,007-0,014	<0,001
Fièvre et/ou historique de fièvre	100,0 %	4,0 %	1,00	-	-
Toux	79,8 %	71,6 %	0,65	0,57-0,73	<0,001
Auscultation pulmonaire anormale	75,9 %	88,2 %	2,36	2,05-2,71	<0,001
Problèmes respiratoires	81,3 %	89,3 %	1,92	1,66-2,22	<0,001
Anorexie	41,5 %	24,6 %	0,45	0,40-0,51	<0,001
Dépendance à l'oxygène	76,8 %	81,5 %	1,33	1,17-1,51	<0,001
Rhinite	19,7 %	9,2 %	0,41	0,33-0,51	<0,001
Mal de gorge	17,9 %	4,1 %	0,19	0,15-0,26	<0,001
Vomissements	14,1 %	9,7 %	0,65	0,53-0,80	<0,001
Malaise	56,2 %	29,0 %	0,32	0,27-0,37	<0,001
Myalgies	22,4 %	5,9 %	0,22	0,17-0,28	<0,001
Nausée	16,5 %	11,0 %	0,63	0,52-0,76	<0,001
Diarrhée	15,9 %	9,3 %	0,54	0,44-0,66	<0,001
Fatigue	54,4 %	22,8 %	0,32	0,28-0,37	<0,001
Douleur thoracique	18,4 %	18,5 %	1,00	0,85-1,18	0,983
Bronchospasme	10,0 %	5,3 %	0,51	0,38-0,68	<0,001
Conscience altérée	13,1 %	9,0 %	0,66	0,35-1,22	0,182
Œdème pulmonaire	6,0 %	3,2 %	0,52	0,35-0,75	0,001
Convulsions	2,8 %	0,0 %	-	-	-
Respiration sifflante	50,1 %	58,8 %	1,41	1,04-1,92	0,027
Confusion	29,6 %	17,4 %	0,48	0,41-0,57	<0,001
Chute soudaine	18,1 %	13,2 %	0,68	0,56-0,82	<0,001

*Rapport de cotes ajusté, corrigé numériquement pour l'âge

Tableau 10: Différences de comorbidités entre les patients SARI selon l'ancienne définition de cas et uniquement la nouvelle définition de cas, par pathogène

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	aOR*	95 % CI	Valeur p
Grippe	N=1212	N=310			
≥1 affection sous-jacente	67,0 %	89,9 %	1,33	0,84-2,11	0,218
Asthme	8,1 %	12,0 %	1,28	0,84-1,96	0,247
Autre maladie respiratoire chronique	18,6 %	38,4 %	1,81	1,35-2,41	<0,001
Maladie cardiovasculaire chronique	21,8 %	44,6 %	1,59	1,19-2,11	0,002
Hypertension	22,7 %	43,0 %	1,39	1,05-1,84	0,022
Diabète	15,6 %	25,4 %	1,08	0,79-1,47	0,640
Obésité	13,3 %	17,1 %	0,89	0,63-1,26	0,520
Insuffisance hépatique	2,5 %	3,6 %	1,01	0,49-2,06	0,984
Insuffisance rénale	12,6 %	22,6 %	1,19	0,85-1,66	0,301
Immunodéficience	7,5 %	8,4 %	0,79	0,50-1,26	0,325
Transplantation d'un organe solide	1,0 %	1,6 %	1,44	0,49-4,23	0,502
Transplantation de cellules souches	1,1 %	2,2 %	1,95	0,68-5,63	0,217
Cancer solide	10,7 %	13,1 %	0,74	0,50-1,09	0,122
Cancer hématologique	4,3 %	6,9 %	1,08	0,63-1,84	0,781
Maladie sanguine non maligne	4,2 %	2,9 %	0,45	0,18-1,09	0,077
Troubles neurologiques	9,2 %	12,4 %	0,96	0,64-1,44	0,832
Troubles neuro-musculaires	2,6 %	3,0 %	0,95	0,44-2,07	0,898
Troubles cognitifs	8,7 %	13,7 %	1,00	0,67-1,50	0,984
Dysplasie broncho-pulmonaire	0,8 %	<1,6 %	0,50	0,06-4,27	0,527
Grossesse**	6,1 %	0,0 %	-	-	-
Prématuré***	6,8 %	0,0 %	-	-	-
Syndrome polymalformatif***	0,0 %	0,0 %	-	-	-
Admission antérieur pour bronchiolite***	4,4 %	11,1 %	2,82	0,33-24,27	0,345
RSV	N=784	N=254			
≥1 affection sous-jacente	42,7 %	67,2 %	0,83	0,50-1,38	0,465
Asthme	8,0 %	9,7 %	0,85	0,49-1,46	0,556
Autre maladie respiratoire chronique	7,7 %	26,2 %	2,31	1,47-3,64	<0,001
Maladie cardiovasculaire chronique	12,8 %	33,2 %	1,23	0,79-1,92	0,351
Hypertension	10,8 %	30,8 %	1,43	0,92-2,23	0,114
Diabète	6,8 %	14,8 %	0,93	0,57-1,53	0,773
Obésité	4,7 %	8,4 %	0,87	0,50-1,57	0,635
Insuffisance hépatique	1,2 %	2,8 %	1,08	0,39-2,99	0,889
Insuffisance rénale	8,3 %	17,2 %	0,78	0,48-1,27	0,314
Immunodéficience	4,6 %	4,0 %	0,39	0,19-0,83	0,014
Transplantation d'un organe solide	<0,6 %	0,0 %	-	-	-
Transplantation de cellules souches	2,4 %	<2,0 %	0,56	0,14-2,21	0,409
Cancer solide	20,0 %	5,7 %	1,12	0,67-1,87	0,664
Cancer hématologique	5,1 %	2,4 %	0,19	0,08-0,47	<0,001
Maladie sanguine non maligne	2,3 %	<2,0 %	0,25	0,05-1,14	0,074
Troubles neurologiques	4,4 %	9,6 %	0,88	0,49-1,58	0,671
Troubles neuro-musculaires	1,1 %	2,8 %	1,15	0,40-3,28	0,792
Troubles cognitifs	4,6 %	9,6 %	0,88	0,48-1,59	0,662
Dysplasie broncho-pulmonaire	1,4 %	<2,0 %	0,78	0,15-3,92	0,758
Grossesse**	5,6 %	7,7 %	7,52	0,13-439,59	0,331
Prématuré***	7,8 %	9,8 %	1,26	0,58-2,73	0,560
Syndrome polymalformatif***	<0,6 %	0,0 %	-	-	-
Admission antérieur pour bronchiolite***	5,0 %	2,2 %	0,61	0,14-2,65	0,506
COVID-19	N=614	N=240			
≥1 affection sous-jacente	80,0 %	91,1 %	0,98	0,51-1,89	0,949
Asthme	5,4 %	7,3 %	1,25	0,67-2,33	0,478
Autre maladie respiratoire chronique	19,8 %	37,9 %	2,08	1,47-2,96	<0,001
Maladie cardiovasculaire chronique	36,9 %	48,1 %	1,13	0,81-1,57	0,473
Hypertension	30,0 %	42,5 %	1,27	0,91-1,77	0,154
Diabète	17,5 %	20,0 %	0,91	0,62-1,35	0,651
Obésité	11,6 %	9,4 %	0,65	0,39-1,09	0,102

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	aOR*	95 % CI	Valeur p
Insuffisance hépatique	3,2 %	3,0 %	0,89	0,36-2,17	0,790
Insuffisance rénale	15,5 %	21,7 %	1,15	0,77-1,71	0,490
Immunodéficience	17,7 %	8,1 %	0,33	0,20-0,56	<0,001
Transplantation d'un organe solide	1,5 %	<2,1 %	0,25	0,03-2,03	0,196
Transplantation de cellules souches	2,4 %	0,0 %	-	-	-
Cancer solide	19,7 %	18,3 %	0,71	0,48-1,06	0,094
Cancer hématologique	10,7 %	6,4 %	0,47	0,26-0,85	0,013
Maladie sanguine non maligne	8,4 %	4,4 %	0,37	0,16-0,86	0,020
Troubles neurologiques	13,8 %	14,2 %	0,83	0,53-1,29	0,408
Troubles neuro-musculaires	7,8 %	<2,1 %	0,17	0,06-0,47	0,001
Troubles cognitifs	13,7 %	9,9 %	0,51	0,30-0,84	0,009
Dysplasie broncho-pulmonaire	0,3 %	0,0 %	-	-	-
Grossesse**	0,0 %	0,0 %	-	-	-
Prématuré***	8,4 %	8,3 %	1,07	0,12-9,31	0,953
Syndrome polymalformatif***	0,9 %	0,0 %	-	-	-
Admission antérieur pour bronchiolite***	1,7 %	0,0 %	-	-	-
hMPV	N=415	N=114			
≥1 affection sous-jacente	58,3 %	82,1 %	0,94	0,47-1,90	0,868
Asthme	9,5 %	13,2 %	0,96	0,49-1,91	0,917
Autre maladie respiratoire chronique	13,7 %	26,3 %	1,09	0,62-1,92	0,763
Maladie cardiovasculaire chronique	17,6 %	37,2 %	0,87	0,50-1,51	0,622
Hypertension	13,7 %	30,7 %	1,00	0,58-1,73	0,999
Diabète	9,6 %	17,5 %	0,81	0,43-1,52	0,514
Obésité	7,3 %	15,8 %	1,03	0,53-1,99	0,938
Insuffisance hépatique	2,0 %	<4,4 %	0,20	0,02-1,66	0,137
Insuffisance rénale	7,1 %	17,5 %	1,16	0,60-2,22	0,664
Immunodéficience	5,5 %	5,3 %	0,45	0,17-1,17	0,101
Transplantation d'un organe solide	<1,2 %	0,0 %	-	-	-
Transplantation de cellules souches	<1,2 %	<4,4 %	2,31	0,31-17,26	0,413
Cancer solide	9,3 %	20,2 %	0,99	0,54-1,82	0,980
Cancer hématologique	3,3 %	7,1 %	1,13	0,44-2,92	0,795
Maladie sanguine non maligne	3,9 %	<4,4 %	0,15	0,02-1,23	0,078
Troubles neurologiques	6,8 %	11,4 %	0,99	0,47-2,09	0,983
Troubles neuro-musculaires	3,8 %	<4,4 %	0,48	0,10-2,29	0,356
Troubles cognitifs	4,1 %	4,8 %	0,50	0,17-1,48	0,212
Dysplasie broncho-pulmonaire	1,2 %	0,0 %	-	-	-
Grossesse**	3,9 %	0,0 %	-	-	-
Prématuré***	10,6 %	16,7 %	1,58	0,42-5,88	0,498
Syndrome polymalformatif***	<1,2 %	0,0 %	-	-	-
Admission antérieur pour bronchiolite***	13,6 %	6,7 %	0,45	0,06-3,52	0,445

*Rapport de cotes ajusté, corrigé pour l'âge catégorisé en 0-4 ; 5-17 ; 18-64 ; 65-79 ; 80+

**Uniquement les femmes âgées de 18-64 ans

***Uniquement les enfants âgés de 0-4 ans

Tableau 11: Différences de comorbidités entre les patients SARI selon l'ancienne définition de cas et uniquement la nouvelle définition de cas, par catégorie d'âge

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	aOR*	95 % CI	Valeur p
0-5 ans	N=2794	N=361			
≥1 affection sous-jacente	26,7 %	29,5 %	1,20	0,93-1,54	0,166
Prématuré	8,4 %	10,9 %	1,31	0,91-1,99	0,149
Syndrome polymalformatif	0,4 %	<1,4 %	0,89	0,11-7,01	0,913
Admission antérieur pour bronchiolite	6,6 %	4,9 %	0,75	0,45-1,28	0,292
Asthme	4,6 %	7,5 %	1,90	1,19-3,05	0,007
Autre maladie respiratoire chronique	3,0 %	3,6 %	1,29	0,71-2,35	0,404
Maladie cardiovasculaire chronique	1,8 %	3,4 %	2,03	1,06-3,87	0,032
Troubles neurologiques	1,6 %	1,7 %	1,11	0,47-2,65	0,810
Dysplasie broncho-pulmonaire	1,2 %	<1,4 %	0,90	0,32-2,54	0,837
6-64 ans	N=1861	N=862			
≥1 affection sous-jacente	77,2 %	87,5 %	1,45	1,13-1,86	0,003
Asthme	14,3 %	17,6 %	1,56	1,23-1,98	<0,001
Autre maladie respiratoire chronique	20,2 %	45,7 %	2,48	2,05-2,99	<0,001
Maladie cardiovasculaire chronique	12,9 %	22,6 %	1,38	1,10-1,72	0,005
Hypertension	17,2 %	24,2 %	1,03	0,83-1,27	0,814
Diabète	13,2 %	15,5 %	0,86	0,67-1,09	0,219
Obésité	18,4 %	17,4 %	0,78	0,63-0,98	0,031
Insuffisance hépatique	3,6 %	4,9 %	1,03	0,68-1,56	0,886
Insuffisance rénale	6,2 %	7,8 %	0,98	0,70-1,36	0,887
Immunodéficience	16,1 %	10,0 %	0,45	0,34-0,58	<0,001
Transplantation d'un organe solide	1,7 %	1,8 %	0,81	0,43-1,52	0,512
Transplantation de cellules souches	3,8 %	2,4 %	0,52	0,30-0,92	0,024
Cancer solide	14,5 %	16,8 %	0,79	0,62-0,996	0,046
Cancer hématologique	9,0 %	5,6 %	0,47	0,33-0,66	<0,001
Maladie sanguine non maligne	5,0 %	2,9 %	0,57	0,33-0,99	0,048
Troubles neurologiques	8,2 %	7,9 %	0,98	0,71-1,35	0,916
Troubles neuro-musculaires	4,4 %	3,2 %	0,85	0,53-1,36	0,504
Troubles cognitifs	3,3 %	3,7 %	1,25	0,78-1,99	0,358
Dysplasie broncho-pulmonaire	0,6 %	<0,6 %	0,59	0,12-2,78	0,501
Grossesse**	2,7 %	2,0 %	1,33	0,53-3,34	0,545
65+ ans	n=3311	n=2912			
≥1 affection sous-jacente	95,9 %	96,6 %	1,20	0,92-1,56	0,186
Asthme	9,7 %	9,5 %	0,98	0,82-1,16	0,796
Autre maladie respiratoire chronique	33,0 %	45,6 %	1,82	1,64-2,03	<0,001
Maladie cardiovasculaire chronique	48,4 %	56,3 %	1,35	1,22-1,50	<0,001
Hypertension	47,2 %	50,6 %	1,13	1,02-1,25	0,016
Diabète	25,9 %	26,9 %	1,06	0,94-1,18	0,358
Obésité	20,5 %	14,5 %	0,66	0,58-0,76	<0,001
Insuffisance hépatique	4,2 %	3,1 %	0,74	0,56-0,97	0,030
Insuffisance rénale	25,4 %	26,0 %	1,00	0,89-1,13	0,984
Immunodéficience	14,5 %	8,0 %	0,52	0,44-0,61	<0,001
Transplantation d'un organe solide	1,2 %	0,6 %	0,57	0,32-0,999	0,050
Transplantation de cellules souches	1,7 %	0,8 %	0,43	0,25-0,73	0,002
Cancer solide	24,6 %	23,0 %	0,92	0,82-1,04	0,188
Cancer hématologique	10,5 %	5,5 %	0,50	0,41-0,61	<0,001
Maladie sanguine non maligne	9,5 %	4,9 %	0,49	0,38-0,63	<0,001
Troubles neurologiques	17,1 %	14,7 %	0,82	0,71-0,94	0,004
Troubles neuro-musculaires	5,5 %	2,1 %	0,36	0,26-0,48	<0,001
Troubles cognitifs	14,8 %	11,7 %	0,71	0,61-0,83	<0,001
Dysplasie broncho-pulmonaire	0,3 %	0,4 %	1,28	0,52-3,16	0,588

*Rapport de cotes ajusté, corrigé numériquement pour l'âge

**Uniquement les femmes

Tableau 12: Différences dans l'évolution de la maladie entre les patients SARI selon l'ancienne définition de cas et uniquement la nouvelle définition de cas, par pathogène

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	aRegr- coef/ aOR*	95 % CI	Valeur p
Grippe	N=1212	N=310			
			<i>aRC</i>		
Durée de séjour (moyenne en jours)	6,9	9,7	0,76	-0,46-2,00	0,222
Durée de séjour (médiane et Q25-Q75)	4 (2-8)	7 (4-12)	1	0,35-1,65	0,002
			<i>aOR</i>		
Admission en soins intensifs	10,2 %	16,5 %	1,37	0,95-1,99	0,095
ECMO	0,5 %	0,0 %	-	-	-
Assistance respiratoire invasive	4,1 %	5,7 %	1,14	0,62-2,10	0,672
Complications					
Au moins 1 complication	33,3 %	36,7 %	0,81	0,62-1,07	0,137
Pneumonie	16,9 %	20,5 %	0,91	0,66-1,27	0,592
Lésion rénale aiguë	8,1 %	13,0 %	1,10	0,74-1,64	0,632
Cardio-vasculaires	6,0 %	7,8 %	0,78	0,47-1,30	0,344
SDRA	6,0 %	7,1 %	0,98	0,59-1,62	0,923
Septicémie	2,8 %	2,9 %	0,75	0,34-1,68	0,490
Surinfection non-pulmonaire	2,0 %	<1,6 %	0,13	0,02-1,01	0,052
Dysfonctionnement hépatique	2,3 %	2,2 %	0,77	0,31-1,94	0,586
Choc	1,5 %	<1,6 %	0,17	0,02-1,00	0,050
Défaillance multi-viscérale (MOF)	0,7 %	1,8 %	1,76	0,56-5,52	0,331
Encéphalite	0,5 %	<1,6 %	0,61	0,07-5,44	0,657
Thromboemboliques	0,5 %	<1,6 %	1,54	0,37-6,35	0,548
Dermatologiques	0,4 %	<1,6 %	0,98	0,10-9,35	0,986
Hémorragie	0,4 %	0,0 %	-	-	-
Convulsions fébriles	0,5 %	<1,6 %	9,69	0,97-96,71	0,053
Syndrome Guillain Barré	<0,4 %	0,0 %	-	-	-
Issue clinique**	N=1110	N=292			
Guéri	92,4 %	86,6 %	0,82	0,54-1,25	0,357
Décédé	4,9 %	8,9 %	1,14	0,69-1,89	0,597
Séquelles	2,7 %	4,5 %	1,32	0,67-2,62	0,421
SARI avec complications***	15,5 %	22,9 %	1,17	0,80-1,56	0,521
RSV	N=784	N=254			
			<i>aRC</i>		
Durée de séjour (moyenne en jours)	5,1	7,4	0,22	-0,63-1,07	0,609
Durée de séjour (médiane et Q25-Q75)	4 (2-6)	5 (3-10)	0	-0,59-0,59	1,000
			<i>aOR</i>		
Admission en soins intensifs	6,3 %	12,3 %	1,79	1,07-5,56	0,025
ECMO	0,0 %	0,0 %	-	-	-
Assistance respiratoire invasive	0,8 %	3,0 %	2,13	0,64-7,03	0,216
Complications					
Au moins 1 complication	28,2 %	32,3 %	0,73	0,51-1,03	0,071
Pneumonie	13,6 %	15,1 %	0,62	0,40-0,97	0,034
Lésion rénale aiguë	4,6 %	9,2 %	0,73	0,41-1,30	0,285
Cardio-vasculaires	3,0 %	6,4 %	0,93	0,46-1,88	0,832
SDRA	5,1 %	8,3 %	1,45	0,81-2,60	0,217
Septicémie	1,8 %	3,0 %	0,69	0,26-1,79	0,442
Surinfection non-pulmonaire	1,0 %	<2,0 %	0,81	0,19-3,43	0,770
Dysfonctionnement hépatique	<0,6 %	<2,0 %	0,35	0,04-3,32	0,360
Choc	<0,6 %	<2,0 %	0,47	0,05-4,90	0,528
Défaillance multi-viscérale (MOF)	<0,6 %	<2,0 %	0,78	0,13-4,77	0,784
Encéphalite	<0,6 %	<2,0 %	1,69	0,32-9,03	0,538

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	aRegr- coef/ aOR*	95 % CI	Valeur p
Thromboemboliques	<0,6 %	<2,0 %	0,96	0,08-12,00	0,974
Dermatologiques	<0,6 %	0,0 %	-	-	-
Hémorragie	0,0 %	0,0 %	-	-	-
Convulsions fébriles	<0,6 %	<2,0 %	2,93	0,26-32,63	0,382
Syndrome Guillain Barré	0,0 %	0,0 %	-	-	-
Issue clinique**	N=709	N=234			
Guéri	95,4 %	87,2 %	0,77	0,44-1,35	0,361
Décédé	3,1 %	10,3 %	1,34	0,71-2,53	0,369
Séquelles	1,6 %	2,6 %	1,13	0,39-3,25	0,817
SARI avec complications***	11,4 %	22,2 %	1,64	1,08-2,51	0,021
COVID-19	N=614	N=240			
			aRC		
Durée de séjour (moyenne en jours)	8,7	9,5	-0,55	-2,46-1,35	0,568
Durée de séjour (médiane et Q25-Q75)	5 (3-10)	7 (4-12)	0	-0,82-0,82	1,000
			aOR		
Admission en soins intensifs	7,2 %	9,2 %	1,21	0,70-2,09	0,492
ECMO	0,0 %	0,0 %	-	-	-
Assistance respiratoire invasive	2,6 %	<2,0 %	0,29	0,07-1,31	0,107
Complications					
Au moins 1 complication	33,6 %	33,5 %	0,80	0,58-1,11	0,179
Pneumonie	17,3 %	18,7 %	0,91	0,61-1,35	0,640
Lésion rénale aiguë	9,8 %	13,2 %	1,09	0,68-1,75	0,716
Cardio-vasculaires	8,0 %	6,6 %	0,63	0,34-1,18	0,147
SDRA	4,3 %	6,3 %	1,30	0,67-2,52	0,433
Septicémie	3,5 %	<2,0 %	0,32	0,09-1,10	0,071
Surinfection non-pulmonaire	1,7 %	<2,0 %	0,79	0,21-2,97	0,730
Dysfonctionnement hépatique	2,4 %	<2,0 %	1,67	0,02-1,28	0,085
Choc	1,3 %	0,0 %	-	-	-
Défaillance multi-viscérale (MOF)	<0,8 %	0,0 %	-	-	-
Encéphalite	0,9 %	0,0 %	-	-	-
Thromboemboliques	1,2 %	0,0 %	-	-	-
Dermatologiques	1,2 %	<2,0 %	0,41	0,05-3,41	0,406
Hémorragie	<0,8 %	0,0 %	-	-	-
Convulsions fébriles	<0,8 %	0,0 %	-	-	-
Syndrome Guillain Barré	0,0 %	0,0 %	-	-	-
Issue clinique**	N=578	N=225			
Guéri	90,1 %	89,8 %	1,20	0,72-2,02	0,480
Décédé	5,2 %	7,1 %	1,11	0,59-2,09	0,747
Séquelles	4,7 %	3,1 %	0,54	0,23-1,27	0,159
SARI avec complications***	11,9 %	15,1 %	1,14	0,72-1,80	0,583
hMPV	N=415	N=114			
			aRC		
Durée de séjour (moyenne en jours)	5,8	8,2	-0,60	-2,33-1,12	0,492
Durée de séjour (médiane et Q25-Q75)	4	6	-1	-1,98-(-0,02)	0,046
			aOR		
Admission en soins intensifs	5,8 %	14,0 %	1,57	0,76-3,22	0,222
ECMO	0,0 %	0,0 %	-	-	-
Assistance respiratoire invasive	1,3 %	<4,4 %	2,33	0,54-10,14	0,259
Complications					
Au moins 1 complication	35,5 %	32,7 %	0,49	0,30-0,81	0,005
Pneumonie	19,6 %	17,7 %	0,46	0,26-0,83	0,010
Lésion rénale aiguë	4,4 %	9,7 %	1,01	0,45-2,27	0,979

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	aRegr- coef/ aOR*	95 % CI	Valeur p
Cardio-vasculaires	4,6 %	8,6 %	0,70	0,29-1,67	0,421
SDRA	6,8 %	7,1 %	0,60	0,26-1,43	0,253
Septicémie	<1,2 %	<4,4 %	0,48	0,05-4,72	0,527
Surinfection non-pulmonaire	<1,2 %	0,0 %	-	-	-
Dysfonctionnement hépatique	1,5 %	<4,4 %	0,29	0,03-2,52	0,262
Choc	0,0 %	0,0 %	-	-	-
Défaillance multi-viscérale (MOF)	0,0 %	0,0 %	-	-	-
Encéphalite	<1,2 %	0,0 %	-	-	-
Thromboemboliques	0,0 %	<4,4 %	-	-	-
Dermatologiques	<1,2 %	0,0 %	-	-	-
Hémorragie	0,0 %	0,0 %	-	-	-
Convulsions fébriles	0,0 %	<4,4 %	-	-	-
Syndrome Guillain Barré	0,0 %	0,0 %	-	-	-
Issue clinique**	N=396	N=112			
Guéri	93,7 %	91,1 %	1,23	0,54-2,80	0,625
Décédé	2,3 %	5,4 %	0,93	0,31-2,74	0,891
Séquelles	4,0 %	<4,5 %	0,72	0,21-2,39	0,585
SARI avec complications***	14,0 %	19,4 %	0,79	0,42-1,50	0,474

* Coefficient de régression ou rapport de cotes, corrigé pour l'âge catégorisé en 0-4 ; 5-17 ; 18-64 ; 65-79 ; 80+

** Les patients transférés ou dont l'issue était inconnue ne sont pas inclus

*** Un cas de SARI est considéré comme compliqué en présence d'un SDRA, d'une admission en soins intensifs, d'un traitement par ECMO, d'une ventilation invasive ou d'un décès

Tableau 13: Différences dans l'évolution de la maladie entre les patients SARI selon l'ancienne définition de cas et uniquement la nouvelle définition de cas, par catégorie d'âge

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	aRegr- coef/ aOR*	95 % CI	Valeur p
0-5 ans	N=2794	N=361			
			<i>aRC</i>		
Durée de séjour (moyenne en jours)	3,38	3,35	-0,06	-0,44-0,31	0,745
Durée de séjour (médiane et Q25-Q75)	2 (2-4)	2 (2-4)	0	-0,41-0,41	1,000
			<i>aOR</i>		
Admission en soins intensifs	3,2 %	7,8 %	2,48	1,60-3,87	<0,001
ECMO	0,0 %	0,0 %	-	-	-
Assistance respiratoire invasive	0,7 %	<1,4 %	1,37	0,39-4,82	0,619
Complications					
Au moins 1 complication	20,3 %	15,0 %	0,70	0,52-0,95	0,023
Pneumonie	7,9 %	2,8 %	0,35	0,18-0,66	0,001
SDRA	2,5 %	4,2 %	1,66	0,94-2,93	0,083
Dermatologiques	1,2 %	<1,4 %	0,47	0,11-1,95	0,295
Surinfection non-pulmonaire	1,1 %	0,0 %	-	-	-
Convulsions fébriles	1,0 %	1,4 %	1,48	0,56-3,87	0,427
Encéphalite	0,4 %	<1,4 %	2,90	0,92-9,16	0,070
Septicémie	0,4 %	<1,4 %	0,62	0,08-4,82	0,651
Dysfonctionnement hépatique	0,4 %	0,0 %	-	-	-
Lésion rénale aiguë	0,3 %	0,0 %	-	-	-
Cardio-vasculaires	0,2 %	<1,4 %	1,56	0,18-13,40	0,686
Choc	0,2 %	0,0 %	-	-	-
Thromboemboliques	<0,2 %	0,0 %	-	-	-
Issue clinique**	N=1110	N=292			
Guéri	97,9 %	99,1 %	2,41	0,75-7,74	0,141
Décédé	0,04 %	0,0 %	-	-	-
Séquelles	2,1 %	<1,7 %	0,42	0,13-1,36	0,150
SARI avec complications***	5,7 %	10,5 %	1,90	1,26-2,85	0,002
6-64 ans	N=1861	N=862			
			<i>aRC</i>		
Durée de séjour (moyenne en jours)	7,7	8,0	-0,60	-1,63-0,44	0,259
Durée de séjour (médiane et Q25-Q75)	4 (3-8)	5 (3-9)	0	-0,36-0,36	1,000
			<i>aOR</i>		
Admission en soins intensifs	14,6 %	19,9 %	1,23	0,99-1,53	0,062
ECMO	0,7 %	0,5 %	0,59	0,18-1,91	0,377
Assistance respiratoire invasive	5,3 %	6,2 %	0,99	0,68-1,47	0,998
Complications					
Au moins 1 complication	39,7 %	33,9 %	0,70	0,58-0,83	<0,001
Pneumonie	23,7 %	19,1 %	0,67	0,54-0,82	<0,001
Lésion rénale aiguë	6,3 %	5,9 %	0,76	0,53-1,08	0,123
SDRA	4,2 %	6,9 %	1,33	0,93-1,90	0,114
Cardio-vasculaires	3,5 %	6,6 %	1,66	1,12-2,47	0,012
Septicémie	4,8 %	2,4 %	0,40	0,24-0,68	0,001
Dysfonctionnement hépatique	2,4 %	1,2 %	0,43	0,20-0,89	0,024
Thromboemboliques	1,3 %	1,9 %	1,21	0,60-2,41	0,596
Surinfection non-pulmonaire	1,5 %	0,9 %	0,50	0,21-1,16	0,107
Choc	1,5 %	1,0 %	0,56	0,23-1,34	0,191
Dermatologiques	1,0 %	<0,6 %	0,28	0,06-1,24	0,094
Défaillance multi-viscérale (MOF)	0,9 %	<0,6 %	0,46	0,15-1,39	0,168
Hémorragie	0,8 %	<0,6 %	0,18	0,23-1,38	0,098
Encéphalite	0,5 %	<0,6 %	0,77	0,16-3,85	0,755

	Ancienne définition de cas	Uniquement nouvelle définition de cas	aRegr- coef/ aOR*	95 % CI	Valeur p
Convulsions fébriles	0,3 %	0,0 %	-	-	-
Issue clinique**	N=709	N=234			
Guéri	90,8 %	89,1 %	0,96	0,72-1,28	0,801
Décédé	3,5 %	5,7 %	1,20	0,80-1,80	0,376
Séquelles	5,8 %	5,2 %	0,89	0,61-1,31	0,560
SARI avec complications***	19,4 %	24,0 %	1,10	0,88-1,37	0,403
65+ ans	n=3311	n=2912			
			aRC		
Durée de séjour (moyenne en jours)	10,6	10,0	-0,61	-1,14- -0,08	0,025
Durée de séjour (médiane et Q25-Q75)	8 (5-13)	7 (4-12)	-0,43	-0,76- -0,10	0,011
			aOR		
Admission en soins intensifs	12,4 %	12,6 %	1,04	0,90-1,22	0,576
ECMO	0,0 %	0,08 %	-	-	-
Assistance respiratoire invasive	3,7 %	3,4 %	0,97	0,72-1,31	0,859
Complications					
Au moins 1 complication	49,0 %	40,2 %	0,69	0,63-0,77	<0,001
Pneumonie	27,2 %	20,8 %	0,70	0,62-0,79	<0,001
Lésion rénale aiguë	15,7 %	14,7 %	0,91	0,79-1,05	0,178
Cardio-vasculaires	10,9 %	12,3 %	1,13	0,96-1,34	0,152
SDRA	5,5 %	5,0 %	0,91	0,73-1,14	0,400
Septicémie	6,2 %	2,6 %	0,40	0,30-0,54	<0,001
Surinfection non-pulmonaire	2,4 %	0,7 %	0,27	0,16-0,47	<0,001
Dysfonctionnement hépatique	2,1 %	0,9 %	0,44	0,27-0,71	0,001
Choc	1,5 %	0,7 %	0,47	0,26-0,86	0,013
Défaillance multi-viscérale (MOF)	0,8 %	0,8 %	0,93	0,51-1,71	0,820
Encéphalite	0,6 %	0,2 %	0,33	0,12-0,89	0,028
Thromboemboliques	1,1 %	1,3 %	1,15	0,70-1,88	0,591
Dermatologiques	0,4 %	0,2 %	0,54	0,19-1,55	0,249
Hémorragie	0,7 %	0,5 %	0,76	0,38-1,55	0,461
Syndrome Guillain Barré	0,03 %	0,0 %	-	-	-
Issue clinique**	N=578	N=225			
Guéri	84,1 %	82,5 %	0,91	0,79-1,04	0,166
Décédé	10,2 %	12,8 %	1,27	1,07-1,49	0,005
Séquelles	5,8 %	4,7 %	0,81	0,64-1,03	0,088
SARI avec complications***	21,6 %	22,5 %	1,06	0,93-1,21	0,367

* Coefficient de régression ou rapport de cotes, corrigé pour l'âge catégorisé en 0–4 ; 5–17 ; 18–64 ; 65–79 ; 80+

** Les patients transférés ou dont l'issue était inconnue ne sont pas inclus

*** Un cas de SARI est considéré comme compliqué en présence d'un SDRA, d'une admission en soins intensifs, d'un traitement par ECMO, d'une ventilation invasive ou d'un décès

CONTACT

Surveillance épidémiologique des infections respiratoires aiguës :
epirespi@sciensano.be

À PROPOS DE SCIENSANO

Sciensano est un institut scientifique public et indépendant, qui oeuvre pour la santé de l'homme et de l'animal et leur environnement.

Nous faisons de la recherche scientifique et de la surveillance et nous soutenons les autorités et différentes agences et organisations par des avis et des services et au travers de notre expertise en matière de santé.

Sciensano accorde une grande importance au principe One Health qui met en exergue que la santé de l'homme, la santé de l'animal et leur environnement sont étroitement liés.

C'est pour cette raison que notre recherche est interdisciplinaire et qu'elle intègre différentes perspectives.

Avec plus de mille collaborateurs et 120 ans d'expertise scientifique, Sciensano est un établissement scientifique de renom, qui fait partie de plusieurs réseaux scientifiques internationaux.

PLUS D'INFOS

Sciensano.be – info@sciensano.be

Rue Juliette Wytsman 14 • Bruxelles • Belgique • T + 32 2 642 51 11